

## ## 1. Adolescencia y salud mental

- Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 1 de cada 25 adolescentes (equivalente al 4 %) ha sufrido un trastorno mental en los últimos 12 meses.
- El estudio \*Salud Mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemia\* reveló que alrededor del 52,2 % de los jóvenes entre 12 y 17 años presentaban entre uno o dos síntomas de ansiedad. La depresión y la ansiedad se identifican como los trastornos más frecuentes en esta población.
- La adolescencia es un período crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental, como:
  - patrones de sueño saludables,
  - ejercicio regular,
  - capacidad para enfrentar situaciones difíciles y resolver problemas,
  - aptitudes interpersonales,
  - gestión de las emociones.
- Contar con un entorno favorable y protector en la familia, la escuela y la comunidad en sentido amplio son factores importantes.
- La salud mental puede verse afectada por múltiples elementos. Cuantos más factores de riesgo estén expuestos los adolescentes —situaciones adversas, presión social del entorno, exploración de la propia identidad—, mayores serán los efectos en su salud mental.
- La influencia de los medios de comunicación y la imposición de normas de género pueden acentuar la disparidad entre la realidad que viven los adolescentes y sus percepciones o aspiraciones de futuro.
- Otros determinantes importantes son el buen ambiente en el hogar y las relaciones con los compañeros.
- La violencia, en particular la violencia sexual y el acoso escolar, una crianza muy severa por parte de los progenitores y los problemas graves de índole socioeconómica o de otro tipo son riesgos conocidos para la salud mental.
- **\*\*Promoción y prevención:\*\*** las intervenciones se centran en mejorar la capacidad para gestionar emociones, enseñar alternativas a las conductas de riesgo, desarrollar resiliencia ante situaciones difíciles o adversas y promover entornos y relaciones sociales saludables.
- Estos programas deben diseñarse con un enfoque integral, que abarque varios canales y espacios —medios digitales, centros sociales y de atención, escuelas o ámbito comunitario— y que use diversas estrategias para llegar a los adolescentes, en especial a los más vulnerables.
- **\*\*Detección y tratamiento tempranos:\*\*** es fundamental abordar las necesidades de los adolescentes con trastornos de salud mental. Evitar la institucionalización y medicalización excesivas, priorizar soluciones no farmacológicas y respetar los derechos de los niños, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos, son aspectos clave.

**\*\*Fuentes:\*\*** DANE; estudio \*Salud Mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemia\*; OMS, \*Salud mental del adolescente\*.

---

## ## 2. Datos globales y carga de morbilidad

- En todo el mundo, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, lo que representa el 15 % de la carga mundial de morbilidad para este grupo etario.
- La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes.
- El suicidio es la tercera causa de defunción en las personas de 15 a 29 años.
- Cuando un trastorno de salud mental de un adolescente no se trata, sus consecuencias se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y limitan sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro.
- En 2021, casi una de cada siete personas (1100 millones) a escala mundial tenía un trastorno mental. Los más habituales son la ansiedad y los trastornos depresivos.
- Aunque existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, la mayoría de las personas con trastornos mentales no tienen acceso a una atención eficaz. Además, muchas son víctimas de estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos.
- **\*\*Conductas de riesgo:\*\***
  - Muchas conductas de riesgo, como el consumo de sustancias o las prácticas sexuales no seguras, se inician en la adolescencia. Pueden ser mecanismos para hacer frente al malestar emocional y afectar muy negativamente al bienestar físico y mental.
  - Los jóvenes tienen más tendencia a adoptar hábitos nocivos de consumo de sustancias que pueden perdurar a lo largo de la vida.
  - En 2019, la prevalencia del consumo de alcohol entre las personas de 15 a 19 años era elevada en todo el mundo (22 %), con muy pocas diferencias por razones de género, y en algunas regiones se observaba un aumento.
  - El consumo de tabaco y de cannabis son motivos de preocupación adicionales. Muchos fumadores adultos adquirieron el hábito antes de los 18 años.
  - En el caso del cannabis, la prevalencia mundial del consumo entre los adolescentes fue, en 2022, superior a la de los adultos: 5,5 % frente a 4,4 %, respectivamente.
  - Algunos adolescentes incurren en actos violentos que pueden afectar al rendimiento académico, causarles lesiones y empujarles a la delincuencia y a situaciones de riesgo para sus vidas. En 2021, la violencia interpersonal se clasificó dentro de las causas principales de muerte entre los adolescentes de mayor edad.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Salud mental del adolescente\*; OMS, \*Trastornos mentales\*.

---

## ## 3. Trastornos mentales: definición, factores y sistemas de salud

- Los trastornos mentales se caracterizan por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, van asociados a angustia o a discapacidad funcional en ámbitos importantes.

- Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. También se denominan afecciones de salud mental, aunque este último término es más amplio y abarca los trastornos mentales, las discapacidades psicosociales y otros estados mentales asociados a una angustia considerable, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva.

- Esta información se centra en los trastornos mentales según la Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11).

- **\*\*Factores de riesgo y protección:\*\*** existe un conjunto diverso de factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales que, en conjunto, protegen o socavan la salud mental. Aunque la mayoría de las personas son resilientes, quienes están expuestos a circunstancias adversas —pobreza, violencia, discapacidad y desigualdad— corren un mayor riesgo.

- Entre los factores de protección y de riesgo se cuentan factores psicológicos y biológicos individuales, como las habilidades emocionales y la genética. Muchos de esos factores se ven influidos por cambios en la estructura o la actividad del cerebro.

- **\*\*Sistemas de salud y apoyo social:\*\*** los sistemas de salud aún no han respondido adecuadamente a las necesidades de las personas que padecen trastornos mentales y no cuentan con los recursos necesarios. Hay una divergencia considerable en todo el mundo entre la necesidad de tratamiento y su prestación, que, cuando se da, suele ser de mala calidad.

- Por ejemplo, solo el 29 % de las personas con psicosis y solo un tercio de las personas con depresión reciben atención de salud mental en un sistema formal.

- Las personas con trastornos mentales también requieren apoyo social, en particular para establecer y mantener relaciones personales, familiares y sociales. También pueden necesitar apoyo en programas educativos, empleo, vivienda y participación en otras actividades significativas.

**\*\*Fuente:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*.

---

## ## 4. Trastornos de ansiedad

### ### 4.1 Generalidades, datos, síntomas y tipos

- Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes del mundo: en 2021 afectaron a 359 millones de personas, incluidos 72 millones de niños y adolescentes.

- Afectan más a las mujeres que a los hombres.

- Sus síntomas suelen aparecer durante la infancia o la adolescencia.

- Existen tratamientos muy eficaces para este tipo de trastornos.

- Aproximadamente una de cada cuatro personas con un trastorno de ansiedad (27,6 %) recibe tratamiento para esa afección.

- Se calcula que un 4,4 % de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad.

- Entre los obstáculos a la atención figuran:

- la falta de concienciación de que el problema es una afección de salud que puede tratarse,
- la falta de inversión en servicios de salud mental,
- la falta de proveedores de atención de salud capacitados,
- el estigma social.

- Todo el mundo puede sentir ansiedad alguna vez, pero las personas con trastornos de ansiedad suelen experimentar miedo y preocupación de manera intensa y excesiva. Estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física y otros síntomas conductuales y cognitivos.

- Son difíciles de controlar, causan una angustia importante y pueden durar mucho tiempo si no se tratan.

- Los trastornos de ansiedad interfieren en las actividades de la vida cotidiana y pueden deteriorar la vida familiar, social y escolar o laboral de una persona.

- Las personas con un trastorno de ansiedad pueden experimentar un miedo o una preocupación excesivos ante una situación específica (como una crisis de angustia o una situación social) o, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, ante una amplia gama de situaciones cotidianas.

- Por lo general, padecen estos síntomas durante un período prolongado, al menos varios meses, y tienden a evitar las situaciones que les generan ansiedad.

- Otros síntomas de los trastornos de ansiedad son:

- dificultad para concentrarse o tomar decisiones,
- irritabilidad, tensión o inquietud,
- náuseas o malestar abdominal,
- palpitaciones,
- sudoración, tiritones o temblores,
- trastornos del sueño,
- sensación de peligro inminente, de pánico o de fatalidad.

- Los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de depresión y de trastornos por consumo de drogas, así como el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas.

- **\*\*Tipos de trastornos de ansiedad:\*\***

- trastorno de ansiedad generalizada (preocupación persistente y excesiva por las actividades o eventos cotidianos);

- trastorno de angustia o pánico (crisis de angustia y miedo a que sigan produciéndose);

- trastorno de ansiedad social (altos niveles de miedo y preocupación por situaciones sociales en las que la persona puede sentirse humillada, avergonzada o rechazada);

- agorafobia (miedo excesivo, preocupación y evitación de situaciones que pueden hacer a alguien entrar en pánico o sentirse atrapado, indefenso o avergonzado);

- trastorno de ansiedad por separación (miedo o preocupación excesivos por estar separado de las personas con las que se tiene un vínculo emocional estrecho);

- determinadas fobias (miedos intensos e irracionales a objetos o situaciones concretos que llevan a conductas de evitación y angustia considerable);

- mutismo selectivo (incapacidad constante para hablar en ciertas situaciones sociales, a pesar de la capacidad de hablar cómodamente en otros entornos; afecta principalmente a los niños).

- Las personas pueden experimentar varios trastornos de ansiedad al mismo tiempo. Por lo general, los síntomas comienzan durante la infancia o la adolescencia y se extienden hasta la edad adulta. Las niñas y las mujeres tienen más probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad que los niños y los hombres.
- **\*\*Causas concomitantes y prevención:\*\*** los trastornos de ansiedad, al igual que otras afecciones de salud mental, son el resultado de una compleja interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos. Cualquier persona puede tener un trastorno de ansiedad, pero las personas que han sufrido abusos, pérdidas importantes u otras experiencias adversas tienen más probabilidades de presentarlo.
- Los trastornos de ansiedad están estrechamente relacionados con la salud física y, por consiguiente, esta influye en ellos. Muchos de los efectos de la ansiedad (como la tensión física, la hiperactividad del sistema nervioso o el consumo nocivo de bebidas alcohólicas) son también factores de riesgo conocidos en determinadas enfermedades, como las cardiovasculares. A su vez, las personas con estas enfermedades también pueden sufrir trastornos de ansiedad por las dificultades asociadas con el manejo de su afección.
- Entre las estrategias comunitarias eficaces para prevenir la ansiedad se encuentran la formación para los progenitores y los programas escolares para promover un aprendizaje social y emocional y para crear mecanismos de afrontamiento positivo en los niños y adolescentes. Los programas basados en el ejercicio físico también pueden ser eficaces para prevenir trastornos de ansiedad en los adultos.
- **\*\*Estrés normal vs. trastorno de ansiedad:\*\*** la vida puede ser estresante. Una persona puede sentirse estresada debido a un trabajo exigente, por su rendimiento en la escuela o por un cambio en la vida. Todas las personas sienten estrés de vez en cuando.
- El estrés es la respuesta física o mental a una causa externa, como tener muchos deberes escolares o una enfermedad. Un factor estresante puede ocurrir una sola vez o a corto plazo, o puede suceder de forma repetida durante mucho tiempo.
- La ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés y puede ocurrir aunque no exista ninguna amenaza actual.
- Si bien es normal tener estrés y ansiedad de vez en cuando, estos no deberían controlar la vida. Si la ansiedad no desaparece y empieza a interferir con las actividades cotidianas, es posible que se tenga un trastorno de ansiedad. Esta distinción aplica al trastorno de ansiedad generalizada, al trastorno de ansiedad social y al trastorno de pánico.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Trastornos de ansiedad\*; NIMH, publicaciones en español.

---

#### ### 4.2 Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)

- La ansiedad ocasional es parte normal de la vida. Muchas personas se preocupan por cosas como la salud, el dinero, la escuela, el trabajo o la familia.
- Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas con mayor frecuencia por estas y otras cosas, incluso cuando la preocupación es desproporcionada con respecto a la situación.
- Por lo general, este trastorno incluye una sensación persistente de ansiedad o pavor que interfiere en la forma en que la persona lleva su vida. No es lo mismo que preocuparse de vez en cuando por las cosas o sentirse ansioso debido a eventos estresantes en la vida. Las personas que tienen este trastorno sienten ansiedad durante meses y hasta años.
- El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente. A menudo comienza durante la adultez temprana, aunque también puede ocurrir a cualquier edad. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de tener este trastorno y algunas mujeres lo tienen durante el embarazo o el período de posparto.

- Con el apoyo y el tratamiento adecuado, las personas con este trastorno pueden controlar su ansiedad y mejorar su calidad de vida.

- **\*\*Signos y síntomas:\*\*** las personas con TAG pueden:

- preocuparse demasiado por las cosas diarias;
- tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo;
- sentirse irritables o con los nervios de punta frecuentemente;
- sentirse inquietas o tener dificultad para relajarse;
- tener problemas para concentrarse;
- tener problemas para dormir o para permanecer dormidas, o sentirse agotadas;
- tener dolores de cabeza, musculares o estomacales, tensión u otros dolores;
- tener temblores o tics (movimientos nerviosos);
- sudar mucho, sentirse mareadas o que les falta el aire;
- tener dificultad para tragar;
- tener que ir al baño a menudo.

- Con frecuencia, los adultos con este trastorno se ponen sumamente nerviosos por situaciones diarias como:

- la seguridad laboral o su rendimiento en el trabajo;
- su salud;
- las finanzas;
- la salud y el bienestar de sus hijos y de otros familiares;
- llegar tarde;
- completar las tareas del hogar y cumplir con otras responsabilidades.

- Los niños y los adolescentes con TAG pueden preocuparse por muchas de las mismas cosas que los adultos, pero sus inquietudes suelen centrarse en la escuela, las actividades extracurriculares, sus amigos y el futuro. Pueden tener dificultades con la incertidumbre y el temor de cometer errores, o preocuparse por decepcionar a los demás. Es posible que se esfuercen por alcanzar la perfección como una forma de controlar la ansiedad.

- Para todas las personas con TAG, los síntomas pueden fluctuar con el tiempo y a menudo empeoran durante momentos de estrés, como una enfermedad física, épocas de exámenes escolares o durante un conflicto familiar o de relaciones personales.

- **\*\*Causas:\*\*** el TAG puede ser hereditario, pero aún no se sabe cuál es la causa exacta. Diversas investigaciones sugieren que este trastorno es provocado por una combinación de la genética, la química del cerebro, la biología y el entorno. Los investigadores han descubierto que las causas externas, como pasar por un evento traumático o estar en un ambiente estresante, pueden aumentar el riesgo de llegar a tener TAG.

- **\*\*Diagnóstico:\*\*** para que le diagnostiquen TAG, una persona debe tener dificultades para controlar sus preocupaciones casi todos los días durante al menos seis meses. La persona también debe tener al menos tres de estos síntomas: sentirse inquieta o con los nervios de punta, sentirse agotada, tener problemas para concentrarse, sentirse irritable, tener tensión muscular o tener problemas para dormir.

- Si se cree que se tienen síntomas de TAG, se debe hablar con un proveedor de atención médica, como un médico de atención primaria, un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social clínico. Durante la

consulta, podrían preguntar cuándo empezaron los síntomas, cuánto tiempo han durado, con qué frecuencia ocurren y qué impacto tienen en la vida. Después de analizar los antecedentes, el proveedor puede realizar un examen físico para asegurarse de que un problema físico no relacionado no esté provocando los síntomas.

- **\*\*Comorbilidades:\*\*** algunas personas con TAG tienen otras afecciones o trastornos mentales y físicos, como depresión, otros trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, síndromes de dolor crónico, problemas cardiovasculares, pensamientos o comportamientos suicidas. Con frecuencia, el TAG también se asocia al consumo indebido de alcohol y otras sustancias.

- La existencia de varios trastornos puede hacer que el tratamiento sea más complejo, y las personas con TAG y otros trastornos mentales concurrentes podrían beneficiarse de un plan de tratamiento integral que aborde todos los aspectos de su salud mental.

- **\*\*Tratamiento específico:\*\*** además de lo descrito en el apartado común de tratamiento de ansiedad, para el TAG se considera la bupiriona. La bupiriona es otro medicamento contra la ansiedad que puede ser útil. A diferencia de las benzodiazepinas, no es un sedante y es menos probable que sea adictivo. La bupiriona debe tomarse durante tres a cuatro semanas para que sea completamente efectiva.

**\*\*Fuente:\*\*** NIMH, publicaciones en español.

---

#### ### 4.3 Trastorno de ansiedad social

- Es un tipo frecuente de trastorno de ansiedad. Una persona con trastorno de ansiedad social siente síntomas de ansiedad o temor en situaciones en las que otros pueden estar analizándola, evaluándola o juzgándola, como:

- hablar en público,
- conocer gente nueva,
- salir con alguien en una cita,
- asistir a una entrevista de trabajo,
- responder una pregunta en clase,
- pedir ayuda,
- tener que hablar con un cajero en una tienda.

- Hacer cosas rutinarias, como comer o beber frente a otras personas o usar un baño público, también puede causar ansiedad o temor debido a la preocupación de que la humillen, la juzguen o la rechacen.

- A menudo, se siente que este temor es incontrolable y puede interferir en la vida cotidiana. Las personas con trastorno de ansiedad social pueden preocuparse por tener que participar en alguna situación social desde semanas antes de que estas se lleven a cabo. A veces, terminan por evitar ir a lugares o eventos que les causan angustia o les generan sentimientos de vergüenza.

- En algunos casos, la ansiedad puede ocurrir en situaciones cuando deben hacer algo delante de otros, como dar un discurso, competir en un juego deportivo o tocar un instrumento musical en el escenario.

- Por lo general, el trastorno de ansiedad social comienza durante la infancia o la adolescencia y puede parecer que la persona tiene timidez extrema o que evita situaciones públicas o interacciones sociales. El

trastorno ocurre con más frecuencia en las mujeres que en los hombres y esta diferencia es más pronunciada en los adolescentes y los adultos jóvenes.

- Con el tratamiento adecuado y con apoyo, las personas con este trastorno pueden controlar su ansiedad y mejorar su calidad de vida.

- **\*\*Signos y síntomas:\*\*** cuando deben hacer algo delante de los demás o están rodeadas de otros, las personas con trastorno de ansiedad social pueden:

- enrojecerse, sudar o temblar;
- tener una frecuencia cardíaca rápida;
- sentir que su “mente se pone en blanco” o tener malestar estomacal;
- mostrar una postura corporal rígida o hablar con una voz sumamente baja;
- tener dificultad para hacer contacto visual, estar con personas que no conocen o hablar en situaciones sociales aun cuando quieran hacerlo;
- sentirse inseguras de sí mismas o temer que se les juzgue negativamente;
- evitar lugares donde hay otras personas o situaciones en las que podrían tener que interactuar con otros;
- analizar sus acciones e identificar fallas autopercebidas en sus interacciones;
- esperar las peores consecuencias posibles de una situación social negativa.

- Los niños y los adolescentes con trastorno de ansiedad social pueden tener síntomas similares a los de los adultos, pero también pueden:

- intentar evitar ir a la escuela,
- tener dificultades para hacer amigos,
- quejarse de dolores de estómago o de cabeza,
- tener arrebatos emocionales en situaciones sociales,
- negarse a hablar o a participar en situaciones sociales.

- En todas las personas con trastorno de ansiedad social, los síntomas pueden fluctuar con el tiempo y a menudo empeoran en momentos de estrés o cambios significativos. Evitar situaciones que provocan ansiedad puede ser útil a corto plazo, pero es probable que sin tratamiento la ansiedad permanezca.

- **\*\*Causas:\*\*** el trastorno de ansiedad social puede ser hereditario, pero nadie sabe con seguridad por qué algunos miembros de la familia lo tienen y otros no. Los investigadores han descubierto que varias partes del cerebro desempeñan cierto papel en el temor y la ansiedad, y que la genética influye en la forma en que funcionan estas áreas. También se está explorando si el estrés y los factores ambientales pueden desempeñar algún papel.

- **\*\*Diagnóstico:\*\*** para que le diagnostiquen trastorno de ansiedad social, una persona debe sentir un fuerte temor o ansiedad frente a situaciones en las que otros podrían juzgarla o analizarla. La persona puede intentar evitar estas situaciones o enfrentarlas con una incomodidad extrema. Estos sentimientos deben durar al menos seis meses e interferir en la vida cotidiana, como el trabajo, la escuela o las relaciones.

- Si se cree que se tienen síntomas, se debe hablar con un proveedor de atención médica, como un médico de atención primaria, un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social clínico. Durante la consulta, podrían preguntar cuándo empezaron los síntomas, cuánto tiempo han durado, con qué frecuencia ocurren y qué impacto tienen en la vida. Después de analizar los antecedentes, el proveedor puede realizar un examen físico para asegurarse de que un problema físico no relacionado no esté provocando los síntomas.

- **\*\*Comorbilidades:\*\*** algunas personas con trastorno de ansiedad social tienen otras afecciones o trastornos mentales y físicos, como depresión, otros trastornos de ansiedad, trastorno



obsesivo-compulsivo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno dismórfico corporal o trastorno bipolar. Con frecuencia, también se asocia al consumo indebido de alcohol y otras sustancias.

- Es menos probable que las personas con trastorno de ansiedad social busquen la ayuda de un proveedor de atención médica para su diagnóstico o tratamiento. A menudo, los proveedores identifican este trastorno cuando tratan a una persona por una enfermedad coexistente.

- La existencia de varios trastornos puede hacer que el tratamiento sea más complejo, y las personas con trastorno de ansiedad social y otros trastornos mentales concurrentes podrían beneficiarse de un plan de tratamiento integral que aborde todos los aspectos de su salud mental.

- **\*\*Tratamiento específico:\*\*** además de lo descrito en el apartado común de tratamiento de ansiedad, se usan betabloqueadores (también conocidos como betabloqueantes). Pueden ayudar a controlar algunos de los síntomas físicos del trastorno de ansiedad social, como la frecuencia cardíaca rápida, la sudoración y los temblores. Por lo general, son el medicamento de preferencia para el tipo de trastorno de ansiedad social conocido como “ansiedad de rendimiento”.

- **\*\*Grupos de apoyo específicos:\*\*** en un grupo de personas en que todas tienen el trastorno de ansiedad social, una persona puede escuchar comentarios imparciales y honestos sobre cómo la ven los demás. Esto le permite descubrir que sus pensamientos de que otros la juzgan o la rechazan no son ciertos o están distorsionados. También puede aprender cómo otros con trastorno de ansiedad social abordan y superan el temor a las situaciones sociales.

**\*\*Fuente:\*\*** NIMH, publicaciones en español.

---

#### ### 4.4 Trastorno de pánico

- Las personas con trastorno de pánico tienen ataques frecuentes e inesperados. Estos ataques se caracterizan por una ola repentina de temor o incomodidad, o bien una sensación de perder el control, incluso cuando no hay un peligro real o un factor desencadenante claro.

- No todas las personas que tienen un ataque de pánico llegarán a tener este trastorno.

- A menudo, los ataques de pánico incluyen síntomas físicos como temblores, hormigueo en el cuerpo o latidos rápidos, que podrían sentirse como si le estuviera dando un ataque al corazón. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento, incluso mientras duermen.

- Muchas personas con este trastorno se preocupan por la posibilidad de tener otro ataque y podrían hacer cambios considerables en sus vidas para evitarlo.

- Los ataques de pánico pueden ocurrir con tanta frecuencia como varias veces al día, o tan poco como unas cuantas veces al año.

- A menudo, el trastorno de pánico comienza a final de la adolescencia o a principios de la edad adulta. Las mujeres tienen una mayor probabilidad que los hombres de llegar a tener este trastorno.

- Con el tratamiento y el apoyo adecuados, las personas con trastorno de pánico pueden controlar los síntomas y mejorar su calidad de vida.

- **\*\*Signos y síntomas:\*\*** las personas con trastorno de pánico pueden tener:

- ataques de pánico repentinos y repetidos con ansiedad y miedo abrumadores;

- una sensación de estar fuera de control;

- miedo a la muerte o a una fatalidad inminente durante un ataque de pánico;
- una preocupación intensa sobre cuándo ocurrirá el próximo ataque de pánico;
- temor de ir o evitar ir a los lugares donde han tenido un ataque de pánico en el pasado.
- Los síntomas físicos durante un ataque de pánico pueden incluir:
  - latidos fuertes o rápidos del corazón,
  - sudor,
  - escalofríos,
  - temblores,
  - dificultad para respirar,
  - debilidad o mareos,
  - hormigueo o entumecimiento de las manos,
  - dolor en el pecho,
  - dolor de estómago o náuseas.
- Un ataque de pánico puede durar desde unos minutos hasta una hora, o a veces más. Aunque estos sentimientos pueden ser angustiosos, los ataques de pánico en sí no ponen en peligro la vida y los síntomas físicos suelen desaparecer con el tiempo. Sin embargo, para algunas personas, el temor a tener futuros ataques puede provocar una ansiedad continua.
- **\*\*Diferencia entre ataque de pánico y trastorno de pánico:\*\*** un ataque de pánico es un episodio que ocurre una sola vez u ocasionalmente y que provoca temor intenso y síntomas físicos y emocionales. Un ataque de pánico aislado no es un trastorno mental. El trastorno de pánico puede diagnosticarse cuando una persona tiene ataques de pánico repentinos y frecuentes, junto con una preocupación constante o cambios en el comportamiento debido al temor de sufrir ataques en el futuro, lo que suele interferir con su vida cotidiana.
- **\*\*Causas:\*\*** a veces, el trastorno de pánico podría ser hereditario, pero nadie sabe con seguridad por qué algunos miembros de una familia lo tienen y otros no. Los investigadores han descubierto que varias partes del cerebro y ciertos procesos biológicos pueden desempeñar un papel fundamental en el temor y la ansiedad. Algunos investigadores consideran que los ataques de pánico son como una “falsa alarma” en la que los instintos normales de supervivencia del cuerpo están activos con demasiada frecuencia o fuerza, o una combinación de ambas.
- Por ejemplo, una persona con trastorno de pánico podría sentir palpitaciones fuertes y asumir que está teniendo un ataque al corazón. Esto puede dar origen a un círculo vicioso, ocasionando que una persona tenga ataques de pánico aparentemente de improviso, que es la característica principal del trastorno de pánico. También se está explorando cómo el estrés y los factores ambientales desempeñan algún papel.
- **\*\*Diagnóstico:\*\*** para que le diagnostiquen trastorno de pánico, una persona debe tener ataques de pánico repentinos y frecuentes. También debe pasar durante al menos un mes preocupándose de que tendrá más ataques, sintiendo miedo de lo que significan estos ataques o modificando su comportamiento para intentar evitar futuros ataques.
- Si se cree que se tienen síntomas, se debe hablar con un proveedor de atención médica, como un médico de atención primaria, un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social clínico. Durante la consulta, podrían preguntar cuándo empezaron los síntomas, cuánto tiempo han durado, con qué frecuencia ocurren y qué impacto tienen en la vida. Después de analizar los antecedentes, el proveedor puede realizar un examen físico para asegurarse de que un problema físico no relacionado no esté provocando los síntomas.
- **\*\*Comorbilidades:\*\*** algunas personas con trastorno de pánico tienen otras afecciones o trastornos mentales y físicos, como depresión, otros trastornos de ansiedad, trastorno por estrés posttraumático, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, enfermedad cardiovascular, trastornos respiratorios,

síndrome del intestino irritable o problemas de tiroides. Con frecuencia, también se asocia al consumo indebido de alcohol y otras sustancias.

- A veces, se puede tener agorafobia de forma concurrente con el trastorno de pánico. Las personas con agorafobia tienen ansiedad o un miedo intenso a ciertos lugares o situaciones en los que escapar u obtener ayuda podría ser difícil o no estar disponible si tienen un ataque de pánico o síntomas similares al pánico.

- La existencia de varios trastornos puede hacer que el tratamiento sea más complejo, y las personas con trastorno de pánico y otros trastornos mentales concurrentes podrían beneficiarse de un plan de tratamiento integral que aborde todos los aspectos de su salud mental.

- **\*\*Tratamiento específico:\*\*** además de lo descrito en el apartado común de tratamiento de ansiedad, se emplea la exposición interoceptiva, una técnica de la terapia cognitivo-conductual que consiste en la exposición a sensaciones corporales asociadas con los ataques de pánico y los síntomas del trastorno de pánico. La terapia de exposición se puede utilizar junto con ejercicios de relajación y técnicas de respiración.

- Los betabloqueadores pueden ayudar a controlar algunos de los síntomas físicos del trastorno de pánico, como la frecuencia cardíaca rápida, la sudoración y los temblores. Aunque los proveedores de atención médica no suelen recetarlos para este trastorno, el medicamento puede ser útil en ciertas situaciones que preceden a un ataque de pánico.

**\*\*Fuente:\*\*** NIMH, publicaciones en español.

---

#### ### 4.5 Tratamiento, cuidado personal, apoyo y recursos para ansiedad

- **\*\*Diagnóstico y tratamiento general:\*\*** existen diversos tratamientos eficaces. Las personas con síntomas de ansiedad deberían buscar atención médica.

- Las intervenciones psicológicas son tratamientos esenciales de los trastornos de ansiedad y consisten principalmente en terapias conversacionales con profesionales o con terapeutas no especializados pero supervisados. Estas intervenciones pueden ayudar a aprender nuevas formas de concebir la ansiedad, hacerle frente y relacionarse tanto con la ansiedad como con las demás personas y con el mundo. De ese modo, pueden enseñar cómo enfrentarse a situaciones, eventos, personas o lugares que provocan ansiedad.

- Las intervenciones psicológicas pueden ofrecerse a individuos o grupos, presencialmente o en línea. También puede accederse a ellas a través de manuales de autoayuda, sitios web y aplicaciones.

- Las intervenciones psicológicas más avaladas por las pruebas para el tratamiento de diversos trastornos de ansiedad son las que se basan en los principios de la terapia cognitivo-conductual. Entre ellas figura la terapia de exposición, en la que la persona aprende a enfrentarse a sus miedos.

- La terapia cognitivo-conductual ha sido muy bien estudiada y es el método de referencia para la psicoterapia. Ayuda a las personas a estar más atentas a sus formas automáticas de pensar que son incorrectas o perjudiciales y posteriormente a cuestionar esos pensamientos, comprender cómo afectan sus emociones y comportamientos, y cambiar los patrones de conductas autodestructivas.

- Otra opción de tratamiento para el TAG y la ansiedad social es la terapia de aceptación y compromiso. Fomenta una aceptación de los pensamientos y los comportamientos sin juzgarlos, y promueve la participación en actividades significativas. Utiliza estrategias como la atención plena y el establecimiento de metas para reducir la incomodidad y la ansiedad. Hay un creciente conjunto de investigaciones que demuestran su eficacia.

- Además, aprender habilidades para gestionar el estrés, como las relacionadas con la relajación y la atención plena (mindfulness), puede ayudar a reducir los síntomas.

#### - **\*\*Medicamentos:\*\***

- Los médicos y otros proveedores de atención médica pueden recetar medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad.

- Los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN), pueden ser eficaces. Con frecuencia se usan para tratar la depresión, pero también pueden ayudar con los síntomas de ansiedad.

- Estos medicamentos pueden tardar varias semanas para que empiecen a funcionar y pueden causar efectos secundarios, como dolores de cabeza, náuseas o dificultad para dormir. Por lo general, estos efectos secundarios no son graves para la mayoría de las personas, en especial si se comienza con una dosis baja y se va aumentando lentamente.

- Los proveedores deben tener presentes los posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a cabo uno u otro tipo de intervención y las preferencias individuales.

- Los ansiolíticos o medicamentos contra la ansiedad incluyen las benzodiazepinas y la buspirona.

- Las benzodiazepinas, que son un tipo de sedantes contra la ansiedad, pueden usarse para ayudar a controlar tipos graves de ansiedad. Pueden ser muy eficaces para disminuir rápidamente la ansiedad, pero algunas personas desarrollan una tolerancia y necesitan dosis cada vez más altas para obtener el mismo efecto. Algunas personas incluso se vuelven dependientes, por lo que el proveedor quizás las recete solo por breves períodos de tiempo. Históricamente se han recetado para los trastornos de ansiedad, pero han dejado de recomendarse por su alto potencial de dependencia y su limitada eficacia a largo plazo.

- La buspirona no es un sedante y es menos probable que sea adictivo. Debe tomarse durante tres a cuatro semanas para que sea completamente efectiva.

- Los betabloqueadores pueden ayudar a controlar síntomas físicos; en ansiedad social se prefieren para la “ansiedad de rendimiento”; en pánico no suelen recetarse, pero pueden ser útiles en ciertas situaciones que preceden a un ataque.

- **\*\*Grupos de apoyo:\*\*** a algunas personas con trastornos de ansiedad les beneficia participar en grupos de autoayuda o de apoyo, y compartir sus problemas y sus logros con otros. Los grupos de apoyo están disponibles tanto en persona como en línea. Sin embargo, cualquier consejo que reciba de un miembro de algún grupo de apoyo debe usarse con cautela y no reemplaza las recomendaciones de tratamiento de un proveedor de atención médica.

- **\*\*Hábitos saludables:\*\*** practicar un estilo de vida saludable también puede ayudar a combatir la ansiedad, aunque esto por sí solo no puede sustituir el tratamiento. Los investigadores han descubierto que escoger ciertas opciones saludables en la vida diaria, como reducir el consumo de cafeína y dormir lo suficiente, puede reducir los síntomas de ansiedad cuando se combina con una atención estándar, como la psicoterapia y los medicamentos.

- Las técnicas para el control del estrés, como el ejercicio, la atención plena y la meditación, también pueden reducir los síntomas de ansiedad e intensificar los efectos de la psicoterapia.

#### - **\*\*Cuidado personal para ansiedad:\*\***

- evitar o reducir el consumo de bebidas alcohólicas y no tomar drogas, ya que pueden empeorar la ansiedad;

- hacer ejercicio a menudo, aunque solo sea dar un paseo;

- seguir, en la medida de lo posible, unos hábitos alimenticios y de sueño regulares, y llevar una dieta sana;

- aprender técnicas de relajación, como la respiración lenta y la relajación muscular progresiva;

- desarrollar el hábito de la meditación de atención plena, aunque solo sean unos minutos al día.

- **\*\*Apoyo a uno mismo o a otras personas con ansiedad:\*\***

- **\*\*Eduquese:\*\*** buscar información sobre signos, síntomas, opciones de tratamiento y mantenerse actualizado con las investigaciones.

- **\*\*Hable con honestidad:\*\*** si tiene síntomas, hable honestamente sobre cómo se siente con alguien en quien confíe. Si cree que un amigo o familiar puede estar luchando, dedique tiempo para hablar con ellos, expresarles su preocupación y hacerles saber que tienen su apoyo.

- **\*\*Sepa cuándo buscar ayuda:\*\*** si la ansiedad comienza a causar problemas en la vida cotidiana, como en la escuela, el trabajo o con amigos y familiares, es momento de buscar ayuda profesional.

- **\*\*Tenga compasión:\*\*** sea amable y paciente consigo mismo y con los demás. Reconozca los avances, por pequeños que sean, y reconozca que controlar el trastorno puede incluir contratiempos en el proceso.

- **\*\*Cómo encontrar ayuda:\*\*** si preocupa la salud mental, hable con un médico u otro proveedor de atención médica. Ellos pueden referirlo a un profesional apto de salud mental, como un psicólogo, un psiquiatra o un trabajador social clínico. También se puede consultar el sitio web del NIMH y el de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA).

- Si usted o alguien que conoce está pasando dificultades o tiene pensamientos suicidas, llame o envíe un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. También puede obtener apoyo a través de su chat en vivo en 988lifeline.org. En situaciones potencialmente mortales, llame al 911.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Trastornos de ansiedad\*; NIMH, publicaciones en español.

---

## ## 5. Depresión

### ### 5.1 Generalidades, datos, síntomas y tipos

- La depresión es un trastorno mental común. Se estima que, en todo el mundo, el 5,7 % de los adultos padecen depresión.

- La depresión afecta más a la mujer que al hombre.

- La depresión puede llevar al suicidio.

- Hay tratamientos eficaces para la depresión, ya sea leve, moderada o grave.

- El trastorno depresivo (o depresión) implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos períodos de tiempo.

- La depresión es distinta de los cambios habituales en el estado de ánimo y en los sentimientos sobre el día a día. Puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias. Puede deberse a problemas en la escuela y laborales o causarlos.

- La depresión puede afectar a cualquiera. Quienes han vivido abusos, pérdidas graves u otros eventos estresantes tienen más probabilidades de sufrirla. Las mujeres son más propensas que los hombres.

- Se estima que el 4,0 % de la población experimenta depresión, incluido el 5,7 % de los adultos (4,6 % entre los hombres y 6,9 % entre las mujeres) y el 5,9 % de los adultos de 70 años o más.

- A escala mundial, aproximadamente 332 millones de personas sufren depresión.

- La depresión es aproximadamente 1,5 veces más frecuente entre las mujeres que entre los hombres.
- En todo el mundo, más del 10 % de las mujeres embarazadas y de las que acaban de dar a luz experimentan depresión.
- En los países de ingreso alto, solamente un tercio de las personas que padecen depresión reciben cuidados de salud mental.
- Entre los obstáculos a una atención eficaz cabe destacar la falta de inversión en atención de salud mental, la falta de proveedores de atención de salud capacitados y la estigmatización a nivel social asociada a los trastornos mentales.
- En 2019, 280 millones de personas tenían depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes.
- **\*\*Síntomas y tipologías:\*\***
  - En un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del placer o del interés por actividades.
  - Un episodio depresivo es distinto de las variaciones habituales del estado de ánimo. Estos episodios abarcan la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas.
  - Pueden presentarse varios síntomas más, como:
    - dificultades para concentrarse,
    - un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima,
    - falta de esperanza acerca del futuro,
    - pensamientos de muerte o suicidio,
    - alteraciones del sueño,
    - cambios en el apetito o en el peso,
    - sensación de cansancio acusado o de falta de energía.
  - La depresión puede causar dificultades en todos los aspectos de la vida, incluidas la vida comunitaria y en el hogar, así como en el trabajo y la escuela.
  - Los episodios depresivos pueden clasificarse en leves, moderados o graves, en función del número y la intensidad de los síntomas, así como de las repercusiones en el funcionamiento de la persona.
  - Los episodios depresivos pueden pertenecer a diferentes tipologías:
    - trastorno depresivo de un solo episodio: la persona experimenta un primer y único episodio;
    - trastorno depresivo recurrente: la persona ha padecido ya al menos dos episodios depresivos;
    - trastorno bipolar: los episodios depresivos alternan con períodos de episodios maníacos, que incluyen euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía, y otros síntomas como aumento de la verborrea, pensamientos acelerados, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente.
- **\*\*Causas concomitantes y prevención:\*\*** la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas (desempleo, luto, eventos traumáticos) tienen más probabilidades de sufrir depresión. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción, y empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia depresión.
- La depresión está estrechamente relacionada con la salud física y, por consiguiente, la salud física desempeña un papel en la depresión. Muchos de los factores que influyen en la depresión (como la inactividad física o el consumo nocivo del alcohol) también son factores de riesgo conocidos para enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias. A su vez,

las personas con estas enfermedades también pueden estar sufriendo depresión a causa de las dificultades asociadas al manejo de su afección.

- Está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión. Entre las estrategias comunitarias eficaces se encuentran los programas escolares para promover un modelo de afrontamiento positivo entre los niños y los adolescentes. Las intervenciones dirigidas a los progenitores de niños con problemas de conducta pueden reducir los síntomas depresivos de los progenitores y mejorar los resultados de sus hijos. Los programas de ejercicio para las personas mayores también pueden ser eficaces para prevenir la depresión.

- **\*\*Diagnóstico y tratamiento:\*\*** hay tratamientos eficaces para la depresión, incluidos los tratamientos psicológicos y la medicación. Se debe buscar cuidados si se presentan síntomas de depresión.

- Los tratamientos psicológicos son el primer tratamiento contra la depresión. Pueden combinarse con antidepresivos en casos de depresión moderada y grave. Los antidepresivos no son necesarios en caso de depresión leve.

- Los tratamientos psicológicos pueden enseñar nuevas maneras de pensar, de hacer frente a las situaciones o de relacionarse con los demás. Pueden incluir terapia conversacional con profesionales y con terapeutas no especializados supervisados. La terapia conversacional puede llevarse a cabo cara a cara o en línea. Puede accederse a tratamientos psicológicos a través de manuales de autoayuda, sitios web y aplicaciones.

- Los tratamientos psicológicos eficaces contra la depresión incluyen:

- la activación conductual,

- la terapia cognitivo-conductual,

- la psicoterapia interpersonal,

- el tratamiento para la resolución de problemas.

- Los antidepresivos incluyen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como la fluoxetina.

- Los proveedores de atención de salud deben tener presentes los posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a cabo uno u otro tipo de intervención y las preferencias individuales.

- Los antidepresivos no se deben utilizar para tratar la depresión en niños ni como tratamiento de primera elección en adolescentes, en quienes hay que utilizarlos con suma cautela.

- Para el trastorno bipolar se utilizan diferentes medicamentos y tratamientos.

- **\*\*Nota:\*\*** la depresión y la ansiedad pueden compartir algunos síntomas, como los cambios repentinos e inesperados del estado de ánimo.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Depresión\*; OMS, \*Trastornos mentales\*.

---

## ### 5.2 Depresión en adolescentes

- La depresión en adolescentes (entre 13 y 17 años) es una enfermedad médica grave. Es más que sentirse triste durante unos días. Es un intenso sentimiento de tristeza, desesperanza e ira o frustración que dura mucho tiempo.

- Estos sentimientos hacen que sea difícil tener una vida normal y hacer las actividades habituales. También puede haber problemas para concentrarse y no tener motivación o energía. La depresión puede hacer difícil disfrutar la vida o incluso superar el día.

- **\*\*Causas:\*\*** muchos factores pueden jugar un papel en la depresión, incluyendo:

- genética: la depresión puede darse en familias;
  - biología cerebral y química;
  - hormonas: los cambios hormonales pueden contribuir a la depresión;
  - eventos estresantes en la niñez como traumas, muerte de un ser querido, intimidación y ciberacoso; y abuso.
- **\*\*Quiénes están en riesgo:\*\*** la depresión puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o al comienzo de la adultez. Ciertos adolescentes tienen un mayor riesgo, como quienes:

- tienen otras afecciones de salud mental, como ansiedad, trastornos de la alimentación y uso de sustancias;
- tienen otras enfermedades, como diabetes, cáncer y enfermedades del corazón;
- tienen familiares con enfermedades mentales;
- tienen un conflicto familiar o una familia disfuncional;
- tienen problemas con amigos u otros compañeros en la escuela;
- tienen discapacidades de aprendizaje o trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH);
- han sufrido un trauma en la infancia;
- tienen baja autoestima, una perspectiva pesimista o poca capacidad de enfrentar situaciones.

- **\*\*Síntomas:\*\*** si se tiene depresión, uno o más de estos síntomas se presentarían con frecuencia:

- tristeza,
- sensación de vacío,
- desesperanza,
- sentir enojo, irritación o frustración, incluso por cosas menores.

- También se pueden tener otros síntomas, como:

- no importan las cosas que solían disfrutarse;
- cambios de peso, como perder peso sin estar a dieta o aumentar de peso por comer demasiado;
- cambios en el sueño, como problemas para quedarse o permanecer dormido, o dormir mucho más de lo normal;
- sentirse inquieto o tener problemas para permanecer sentado;
- sentirse muy cansado o no tener energía;
- sentirse sin valor o muy culpable;
- tener problemas para concentrarse, recordar información o tomar decisiones;
- pensar en la muerte o suicidio.

- **\*\*Diagnóstico:\*\*** si se cree que se está deprimido, se debe decir a alguien en quien se confíe, por ejemplo:



- padres o tutores,
- maestros o consejeros,
- médicos.
- El siguiente paso es visitar al médico para un chequeo. El médico puede primero asegurarse de que no hay otro problema de salud que esté causando la depresión. Para hacer esto, es posible que haga un examen físico y pruebas de laboratorio.
- Si no hay otro problema de salud, se obtendrá una evaluación psicológica. El médico puede hacerla o puede referir a un profesional de salud mental. Se pueden hacer preguntas sobre:
  - pensamientos y sentimientos,
  - cómo va en la escuela,
  - cualquier cambio en alimentación, sueño o energía,
  - si se piensa en suicidarse,
  - si se usa alcohol o drogas.

**\*\*Fuente:\*\* MedlinePlus / NIMH, publicaciones en español.**

---

### ### 5.3 Cuidado personal y pensamientos suicidas en depresión

- El cuidado personal puede ser clave en el manejo de los síntomas de la depresión, así como en el fomento del bienestar general.
- **\*\*¿Qué puede hacer?\*\***
  - Trate de seguir haciendo cosas que solía disfrutar.
  - Mantenga el contacto con amigos y familia.
  - Haga ejercicio a menudo, aunque solo sea dar un paseo.
  - Siga, si es posible, unos hábitos alimenticios y de sueño regulares.
  - Evite o reduzca el consumo de alcohol y no tome drogas ilícitas, que pueden empeorar la depresión.
  - Cuente a alguien de confianza cómo se siente.
  - Acuda a un proveedor de atención de salud.
- **\*\*Si tiene pensamientos suicidas:\*\***
  - Recuerde que no está solo, que muchos han pasado por esto y encontraron ayuda.
  - Cuente a alguien de confianza cómo se siente.
  - Hable con un trabajador de la salud (un médico o un consejero).
  - Únase a un grupo de apoyo.

- Si cree que existe el peligro de que, a corto plazo, pueda hacerse daño, póngase en contacto con un servicio de emergencia o con una línea de atención telefónica para situaciones de crisis.

**\*\*Fuente:\*\*** OMS, \*Depresión\*; NIMH.

---

## ## 6. Otros trastornos mentales

### ### 6.1 Trastorno bipolar

- En 2021, 37 millones de personas tenían trastorno bipolar, entre ellas 3,8 millones de adolescentes entre 10 y 19 años.

- Las personas con trastorno bipolar experimentan episodios depresivos alternados con períodos de síntomas maníacos.

- Durante el episodio depresivo, experimentan un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la mayor parte del día, casi todos los días.

- Los síntomas maníacos pueden incluir euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía y otros síntomas, como aumento de la verborrea, pensamientos acelerados, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente.

- Las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de cometer suicidio.

- Existen opciones terapéuticas eficaces, como psicoeducación, reducción del estrés y fortalecimiento del funcionamiento social, y medicación.

- Para el trastorno bipolar se utilizan diferentes medicamentos y tratamientos.

**\*\*Fuente:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*; OMS, \*Depresión\*.

### ### 6.2 Trastorno de estrés postraumático (TEPT)

- Este trastorno puede desarrollarse después de la exposición a un suceso o serie de sucesos extremadamente amenazantes u horribles.

- Se caracteriza por todo lo siguiente:

1. volver a experimentar el suceso o sucesos traumáticos en el presente (recuerdos intrusivos, escenas retrospectivas o pesadillas);

2. evitar pensamientos y recuerdos del suceso o sucesos, o evitar actividades, situaciones o personas que recuerden al suceso o sucesos;

3. percepciones persistentes de una mayor amenaza actual.

- Estos síntomas duran al menos varias semanas y causan una discapacidad funcional importante.

- Existe un tratamiento psicológico eficaz.

**\*\*Fuente:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*.

### ### 6.3 Esquizofrenia y trastornos psicóticos

- A escala mundial, la esquizofrenia afecta a unos 23 millones de personas, es decir, a una de cada 345 personas.
- Las personas con esquizofrenia tienen una esperanza de vida nueve años inferior a la de la población general.
- La esquizofrenia se caracteriza por una importante deficiencia en la percepción y por cambios de comportamiento.
- Los síntomas pueden incluir persistencia de ideas delirantes, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento muy desorganizado o agitación extrema.
- Las personas con esquizofrenia pueden ver entorpecidas de forma persistente sus capacidades cognitivas.
- Existen diversas opciones terapéuticas eficaces, entre las que se cuentan la medicación, la psicoeducación, las intervenciones familiares y la rehabilitación psicosocial.
- Los trastornos psicóticos suelen aparecer a finales de la adolescencia o principios de la edad adulta y causan síntomas como alucinaciones o delirios. Son experiencias que pueden afectar a la capacidad del adolescente para realizar actividades cotidianas y para el aprendizaje y que, en muchos casos, conducen a la estigmatización o a violaciones de los derechos humanos.
- Un 0,1 % de los adolescentes de 15 a 19 años sufre esquizofrenia.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*; OMS, \*Salud mental del adolescente\*.

### ### 6.4 Trastornos del comportamiento alimentario

- En 2021, 16 millones de personas tenían trastornos alimentarios, de los que casi 3,4 millones eran niños y adolescentes.
- Los trastornos del comportamiento alimentario, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, se caracterizan por alteraciones en la alimentación y preocupación por los alimentos, así como por una inquietud desmedida por el peso y la forma corporales.
- Los síntomas o comportamientos dan lugar a un riesgo o daño considerables para la salud, una angustia notable o una discapacidad funcional importante.
- La anorexia nerviosa suele aparecer durante la adolescencia o a principios de la edad adulta y puede provocar una muerte prematura debido a complicaciones médicas o al suicidio.
- Las personas con bulimia nerviosa tienen un riesgo significativamente mayor de abuso de sustancias, suicidio y complicaciones de salud.
- Existen opciones de tratamiento eficaces, como el tratamiento de base familiar y la terapia cognitiva.

- Los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia nerviosas, suelen aparecer durante la adolescencia y la juventud. Se manifiestan con conductas alimentarias anormales y preocupación por la alimentación y, en la mayoría de los casos, por el peso y la figura corporales, y son más frecuentes en las adolescentes que en los varones de esa misma franja de edad.
- Pueden afectar a la salud física y, a menudo, coexisten con la depresión, la ansiedad y el consumo indebido de sustancias.
- Se estima que afectan a un 0,1 % de los adolescentes de 10 a 14 años y a un 0,4 % de los de 15 a 19 años, y están asociados al suicidio.
- La anorexia nerviosa puede llevar a la muerte prematura, a menudo debido a complicaciones médicas o al suicidio, y su tasa de mortalidad es superior a la de cualquier otro trastorno mental.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*; OMS, \*Salud mental del adolescente\*.

#### ### 6.5 Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial

- En 2021, 41 millones de personas, incluidos niños y adolescentes, tenían un trastorno de comportamiento disocial.
- Este trastorno, también conocido como trastorno de conducta, es uno de los dos trastornos de comportamiento disruptivo y disocial; el otro es el trastorno desafiante y oposicionista.
- Los trastornos de comportamiento disruptivo y disocial se caracterizan por problemas de comportamiento persistentes, como comportamientos persistentemente desafiantes o desobedientes que violan de manera permanente los derechos básicos de los demás o las principales normas, reglas o leyes sociales apropiadas para la edad.
- Suelen aparecer durante la infancia, aunque no siempre es el caso.
- Existen tratamientos psicológicos eficaces, como la resolución de problemas cognitivos y/o la capacitación en habilidades sociales, en los que a menudo intervienen los progenitores, los cuidadores y los maestros.

**\*\*Fuente:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*.

#### ### 6.6 Trastornos del neurodesarrollo

- Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos del comportamiento y cognitivos que surgen durante el desarrollo y que dan lugar a dificultades considerables en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motoras o sociales específicas.
- Incluyen trastornos del desarrollo intelectual, trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), entre otros.
- El TDAH se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad-impulsividad que tiene un impacto negativo directo en el funcionamiento académico, ocupacional o social.
- Los trastornos del desarrollo intelectual se caracterizan por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y el comportamiento adaptativo, que se refiere a dificultades con las habilidades conceptuales, sociales y prácticas cotidianas en la vida diaria.

- El trastorno del espectro autista (TEA) constituye un grupo diverso de afecciones caracterizadas por cierto grado de dificultad con la comunicación social y la interacción social recíproca, así como patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos e inflexibles.

- Existen opciones terapéuticas eficaces, que incluyen intervenciones psicosociales y del comportamiento, terapia ocupacional y logoterapia. Para determinados diagnósticos y grupos de edad, también se puede considerar la medicación.

**\*\*Fuente:\*\* OMS, \*Trastornos mentales\*.**

---

## ## 7. Suicidio

### ### 7.1 Datos, factores de riesgo y señales de advertencia

- El suicidio es acabar con la propia vida. Con frecuencia, se ve como una manera de dar fin a la desesperanza o frustración abrumadora, o de resolver un problema para el que no se encuentra una solución.

- El suicidio de una persona joven es devastador para la familia, los amigos y la comunidad. Los padres, los hermanos, los compañeros de clase, los entrenadores y los vecinos tal vez se sientan enojados o culpables, o se pregunten si podrían haber hecho algo para impedirlo.

- El suicidio es la tercera causa de defunción entre los adolescentes mayores y los jóvenes (entre 15 y 29 años).

- En 2021, 727 000 personas se quitaron la vida.

- De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 10 y los 14 años, y la tercera causa de muerte entre los 15 y los 24 años, solo detrás de los accidentes y los homicidios.

- También se cree que por cada suicidio adolescente hay muchos más intentos de suicidio.

- Los factores de riesgo del suicidio son diversos: el consumo nocivo de bebidas alcohólicas, el maltrato en la infancia, la estigmatización (que disuade de buscar ayuda), los obstáculos que impiden recibir atención y el acceso a medios para suicidarse.

- Las plataformas digitales, al igual que otros medios, pueden desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a aplicar medidas de prevención del suicidio, pero también pueden debilitar estas medidas.

- Aproximadamente el 95 % de las personas que fallecen debido a un suicidio tienen un trastorno psicológico en el momento de su muerte.

- Las cosas que pueden incrementar el riesgo de suicidio entre los adolescentes incluyen:

- un trastorno psicológico, en especial la depresión, el trastorno bipolar y el consumo de alcohol y drogas;

- sentimientos de angustia, irritabilidad o nerviosismo;

- sentimientos de desesperanza e impotencia, que suelen estar acompañados de depresión;

- un intento de suicidio anterior;

- antecedentes de depresión o suicidio en la familia;
- abuso sexual, emocional o físico;
- falta de una red de apoyo, malas relaciones con los padres o sus pares, y sentimiento de aislamiento social;
- problemas con la identidad de género o la sexualidad en una familia o una comunidad que no da apoyo.
- **\*\*Adolescentes en riesgo:\*\*** las personas jóvenes con problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, trastorno bipolar o insomnio, tienen más riesgos de tener pensamientos suicidas. Los adolescentes que atraviesan grandes cambios en sus vidas (el divorcio de sus padres, una mudanza, la partida de uno de los padres debido al servicio militar o la separación de los padres, los cambios económicos) y quienes son víctimas del acoso escolar, el racismo o la estigmatización tienen más riesgos de tener pensamientos suicidas.
- **\*\*Señales de advertencia:\*\*** los adolescentes que están pensando en el suicidio tal vez hagan lo siguiente:
  - hablar sobre el suicidio o la muerte en general;
  - dar a entender que tal vez ya no estén aquí mucho tiempo;
  - hablar sobre sentimientos de desesperanza o de culpa;
  - alejarse de los amigos o la familia;
  - escribir canciones, poemas o cartas sobre la muerte, la separación y la pérdida;
  - comenzar a regalar posesiones muy queridas a sus hermanos o amigos;
  - perder el deseo de participar en sus actividades favoritas;
  - tener dificultad para concentrarse o pensar con claridad;
  - sufrir cambios en los hábitos de alimentación y de sueño;
  - comenzar a tener comportamientos de riesgo;
  - perder el interés en la escuela o los deportes.
- Los suicidios en los adolescentes suelen ocurrir después de un acontecimiento estresante, como problemas en la escuela, el fin de una relación con un novio o una novia, el fallecimiento de un ser querido, un divorcio o un grave conflicto familiar.
- **\*\*Acceso a medios:\*\*** el riesgo de suicidio se incrementa enormemente cuando los niños y los adolescentes tienen acceso a armas de fuego en el hogar, y cerca del 60 % de todos los suicidios de los Estados Unidos son cometidos con un arma de fuego. Por eso, si hay armas de fuego en el hogar, deben estar descargadas, bajo llave y fuera del alcance de los niños y los adolescentes.
- Las sobredosis con medicamentos de venta libre, con receta y sin receta también son un riesgo muy común para los intentos de suicidio y los suicidios. Es importante controlar atentamente todos los medicamentos que hay en el hogar. Los adolescentes intercambian diferentes medicamentos con receta en las escuelas y los llevan o almacenan en sus mochilas o casilleros.
- **\*\*Diferencias por sexo:\*\*** las muchachas piensan en suicidarse e intentan suicidarse con una frecuencia dos veces mayor a los muchachos y suelen intentar suicidarse con una sobredosis de drogas o cortándose. Sin embargo, la frecuencia de muertes por suicidio en los muchachos cuadruplica a la de las niñas. Los expertos creen que esto se debe a que suelen usar métodos más letales.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Salud mental del adolescente\*; KidsHealth, \*Suicidio\*; MedlinePlus, \*Evaluación del riesgo de suicidio\*.

## ### 7.2 Qué pueden hacer los padres y cuidadores

- Muchos adolescentes que se suicidan o intentan suicidarse advirtieron de alguna manera a sus seres queridos. Por eso, es importante que los padres sepan cuáles son las señales de advertencia para que los adolescentes que quizás tengan pensamientos suicidas puedan recibir la ayuda que necesitan.
- Si bien no siempre es posible prevenir un suicidio, siempre es conveniente estar informado y tomar medidas para ayudar a un adolescente atormentado.
- Algunos adultos creen que los niños o muchachos que dicen que se van a lastimar o quitar la vida “solo lo hacen para recibir atención”. Es importante darse cuenta de que si se ignora a un adolescente que está buscando atención, las probabilidades de que se autolesione son mayores.
- En general, los adolescentes no quieren recibir atención bajo la forma de visitas a la sala de emergencias, citas con los médicos y tratamientos en instituciones de salud mental, salvo que estén gravemente deprimidos y pensando en suicidarse o al menos deseando estar muertos. Es importante ver estas señales de advertencia como graves y no como un “pedido de atención” que se puede ignorar.
- **\*\*Observe y escuche:\*\*** observe atentamente a un adolescente deprimido y retraído. Comprender la depresión en los adolescentes es muy importante porque puede ser muy diferente de las creencias comunes acerca de la depresión. Por ejemplo, puede darse como problemas con los amigos, las calificaciones, el sueño o como mal humor o irritabilidad en lugar de tristeza crónica o llanto.
- Intente mantener abiertos los canales de comunicación y exprese su preocupación, su apoyo y su amor. Si su hijo adolescente le confía sus problemas, demuéstrole que toma en serio sus preocupaciones. Tal vez una pelea con un amigo a usted no le parezca tan importante, pero para un adolescente puede ser algo tremendo y agotador. No minimice ni ignore lo que le pasa.
- Si su hijo adolescente no se siente cómodo como para hablar con usted, sugiérale una persona más neutral, como otro pariente, un integrante del clero, un entrenador, un consejero escolar o su propio médico.
- **\*\*Haga preguntas:\*\*** algunos padres dudan si preguntarles a sus hijos adolescentes si han estado pensando en el suicidio o en autolesionarse. Algunos temen que hacer preguntas haga pensar a su hijo en la idea del suicidio. Siempre es una buena idea preguntar, aunque pueda ser difícil. A veces, explicar por qué hace esas preguntas puede resultar útil. Por ejemplo: “He notado que has estado hablando mucho de tu deseo de estar muerto. ¿Has estado pensando en quitarte la vida?”.
- **\*\*Cómo obtener ayuda:\*\*** si se entera de que su hijo está pensando en el suicidio, obtenga ayuda inmediatamente. El médico puede derivarlo a un psicólogo o psiquiatra, o el departamento de psiquiatría de su hospital local puede darle una lista de los médicos de su zona. La asociación de salud mental local o la sociedad médica del condado también pueden darle referencias. En caso de emergencia, llame al 1-888-628-9454 (para español) o envíe un mensaje de texto o llame al 988.
- Si su hijo adolescente está en una crisis, la sala de emergencias local puede hacer una evaluación psiquiátrica y derivarlo a los recursos adecuados. Si no está seguro de si debe llevar a su hijo a la sala de emergencias, llame al médico.
- Si tiene una visita programada con un profesional de la salud, no deje de acudir a ella, aun cuando su hijo adolescente le diga que se está sintiendo mejor o que no va a ir. Es normal que los pensamientos suicidas vayan y vengan. Pero su hijo adolescente necesita ayuda a fin de desarrollar las habilidades necesarias para mantener los pensamientos y las conductas suicidas bajo control durante una crisis.
- Si su hijo adolescente se niega a ir a la visita, dígaselo al profesional de la salud mental. Si usted acude a la sesión y trabaja con el médico, continuará teniendo acceso a la ayuda que su hijo necesita. El médico también puede conversar con usted sobre maneras de ayudar a que su hijo adolescente acepte ayuda.
- Recuerde que los conflictos entre un padre y un hijo pueden empeorar las cosas para los adolescentes que se sienten aislados, incomprensidos, desvalorizados o con tendencias suicidas. Obtenga ayuda para los problemas familiares y resuélvalos sanamente. Informe al profesional de la salud mental si su familia

tiene antecedentes de depresión, abuso de sustancias o violencia doméstica. Hable sobre cualquier otra causa de estrés en el hogar, como un ambiente continuo de criticismo.

**\*\*Fuente:\*\* KidsHealth, \*Suicidio\*.**

### ### 7.3 Si perdió a un hijo debido a un suicidio

- Para los padres, la muerte de un hijo es la pérdida más dolorosa que se pueda imaginar. Para los padres que han perdido a un hijo debido a un suicidio, el dolor y la pérdida pueden ser más intensos. Estos sentimientos tal vez nunca desaparezcan por completo. Pero quienes sobreviven a un suicidio pueden tomar medidas para comenzar el proceso de sanación:

- **\*\*Manténgase en contacto con los demás.\*\*** El suicidio puede dejar aislados a los integrantes de la familia porque, con frecuencia, los amigos no saben qué decir o cómo ayudar. Busque personas que le den su apoyo y con quienes pueda hablar acerca de su hijo y de sus sentimientos. Si quienes lo rodean parecen sentirse incómodos o no saben cómo acercarse a usted, comience usted la conversación y pídale su ayuda.

- **\*\*Recuerde que los demás integrantes de su familia también están atravesando el duelo\*\*** y que cada uno expresa su dolor a su manera. Sus otros hijos, en especial, pueden intentar enfrentar el dolor solos para no sobrecargarlo. Estén el uno para el otro para compartir las lágrimas, el enojo y los silencios; y si es necesario, obtengan ayuda y apoyo juntos.

- **\*\*Sepa que los aniversarios, los cumpleaños o las fiestas pueden ser momentos muy duros.\*\*** Las fechas importantes y las fiestas suelen reavivar la sensación de pérdida y ansiedad. En esas fechas, haga lo que sea mejor para sus necesidades emocionales, ya sea rodearse de familiares y amigos, o planear un día sereno de reflexión.

- **\*\*Comprenda que es normal sentirse culpable y preguntarse cómo pudo ocurrir algo así.\*\*** Pero también es importante que se dé cuenta de que tal vez nunca encuentre las respuestas que busca. La sanación que se da con el tiempo surge de llegar a perdonar a su hijo y de perdonarse a usted mismo.

- **\*\*Los grupos de terapia y apoyo\*\*** pueden desempeñar un papel importante para ayudarlo a darse cuenta de que no está solo. A veces, los integrantes de la familia que están afligidos se convierten en parte de la red de prevención de suicidios que ayuda a los padres, los adolescentes y las escuelas a intentar prevenir futuras tragedias.

**\*\*Fuente:\*\* KidsHealth, \*Suicidio\*.**

### ### 7.4 Ayudar a los adolescentes a aceptar una pérdida

- ¿Qué debe hacer si alguien a quien su hijo adolescente conoce ha intentado suicidarse o se ha suicidado? En primer lugar, reconozca y valide las emociones de su hijo. Algunos adolescentes dicen sentirse culpables, en especial aquellos que sienten que podrían haber interpretado mejor las palabras y los actos de su amigo.

- Otros dicen sentirse enojados con la persona que se suicidó o intentó suicidarse por haber hecho algo tan egoísta. Y otros dicen que no sienten ninguna emoción intensa o que no saben cómo expresar lo que sienten. Tranquilece a su hijo explicándole que no hay una manera correcta de sentirse y que está bien que hable del tema cuando se sienta preparado.



- Cuando una persona intenta suicidarse y sobrevive, las personas pueden tener miedo o sentirse incómodas como para hablar con ella sobre el tema. Dígale a su hijo que resista este impulso; este es un momento en el que una persona necesita sentirse conectada con los demás.

- Muchas escuelas abordan el suicidio de un estudiante llamando a un psicólogo especial para que hable con los estudiantes y los ayude a afrontar la situación. Si su hijo adolescente está enfrentando el suicidio de un amigo o un compañero de clase, anímelo a usar estos recursos o a hablar con usted u otro adulto en quien confíe.

**\*\*Fuente:\*\* KidsHealth, \*Suicidio\*.**

### ### 7.5 Evaluación del riesgo de suicidio

- **\*\*¿Qué es una evaluación del riesgo de suicidio?\*\*** El suicidio es la muerte que ocurre cuando una persona se daña a sí misma porque quiere acabar con su vida. Es una importante preocupación de salud pública y una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos y el mundo.

- El suicidio y los intentos de suicidio pueden tener efectos dañinos duraderos:

- Las personas que sobreviven un intento de suicidio pueden tener lesiones severas que pueden afectar su salud a largo plazo. También pueden tener depresión u otros problemas de salud mental.

- Cuando las personas mueren por suicidio, esto afecta a sus familiares, amigos y comunidades. Pueden sentir duelo, estrés agudo, enojo y culpa. Algunas personas pueden desarrollar estrés postraumático, depresión o ansiedad. También pueden tener más riesgo de presentar pensamientos suicidas.

- Con frecuencia, el suicidio puede prevenirse. Una evaluación del riesgo de suicidio puede ayudar a determinar la probabilidad de que una persona intente suicidarse. En la mayoría de las evaluaciones, un profesional de la salud hará algunas preguntas sobre el comportamiento y los sentimientos. Hay preguntas y pautas específicas que los profesionales de la salud pueden utilizar. A estas se las conoce como herramientas de evaluación del riesgo suicida. Si se determina que usted o un ser querido está en riesgo de suicidio, hay apoyo médico, psicológico y emocional disponible que puede evitar un desenlace trágico.

- **\*\*Nombres alternativos:\*\*** valoración del riesgo de suicidio.

- **\*\*¿Para qué se usa?\*\*** La evaluación del riesgo de suicidio se usa para averiguar si una persona está en riesgo de intentar suicidarse.

- **\*\*¿Por qué necesito una evaluación del riesgo de suicidio?\*\*** Usted o un ser querido podría necesitar una evaluación si nota cualquiera de los siguientes signos de advertencia:

- se siente sin esperanza o atrapado;
- habla de ser una carga para los demás;
- aumenta su consumo de alcohol o drogas;
- tiene altibajos emocionales extremos;
- tiene mayor ansiedad;
- evita las situaciones sociales o quiere estar solo;
- cambian sus hábitos de sueño o alimentación.

-# Salud mental en adolescentes: información organizada por temas

**\*\*Nota de organización:\*\*** Se consolidó la información de las fuentes aportadas. Se eliminaron repeticiones y se agruparon contenidos equivalentes. No se resume: se conservan datos, síntomas, tratamientos, recomendaciones y advertencias. Las fuentes se indican al final de cada sección y en el listado final.

---

## ## 1. Adolescencia y salud mental

- Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 1 de cada 25 adolescentes (equivalente al 4 %) ha sufrido un trastorno mental en los últimos 12 meses.
- El estudio \*Salud Mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemia\* reveló que alrededor del 52,2 % de los jóvenes entre 12 y 17 años presentaban entre uno o dos síntomas de ansiedad. La depresión y la ansiedad se identifican como los trastornos más frecuentes en esta población.
- La adolescencia es un período crucial para el desarrollo de hábitos sociales y emocionales importantes para el bienestar mental, como:
  - patrones de sueño saludables,
  - ejercicio regular,
  - capacidad para enfrentar situaciones difíciles y resolver problemas,
  - aptitudes interpersonales,
  - gestión de las emociones.
- Contar con un entorno favorable y protector en la familia, la escuela y la comunidad en sentido amplio son factores importantes.
- La salud mental puede verse afectada por múltiples elementos. Cuantos más factores de riesgo estén expuestos los adolescentes —situaciones adversas, presión social del entorno, exploración de la propia identidad—, mayores serán los efectos en su salud mental.
- La influencia de los medios de comunicación y la imposición de normas de género pueden acentuar la disparidad entre la realidad que viven los adolescentes y sus percepciones o aspiraciones de futuro.
- Otros determinantes importantes son el buen ambiente en el hogar y las relaciones con los compañeros.
- La violencia, en particular la violencia sexual y el acoso escolar, una crianza muy severa por parte de los progenitores y los problemas graves de índole socioeconómica o de otro tipo son riesgos conocidos para la salud mental.
- **\*\*Promoción y prevención:\*\*** las intervenciones se centran en mejorar la capacidad para gestionar emociones, enseñar alternativas a las conductas de riesgo, desarrollar resiliencia ante situaciones difíciles o adversas y promover entornos y relaciones sociales saludables.
- Estos programas deben diseñarse con un enfoque integral, que abarque varios canales y espacios —medios digitales, centros sociales y de atención, escuelas o ámbito comunitario— y que use diversas estrategias para llegar a los adolescentes, en especial a los más vulnerables.
- **\*\*Detección y tratamiento tempranos:\*\*** es fundamental abordar las necesidades de los adolescentes con trastornos de salud mental. Evitar la institucionalización y medicalización excesivas, priorizar soluciones no farmacológicas y respetar los derechos de los niños, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos de derechos humanos, son aspectos clave.

**\*\*Fuentes:\*\*** DANE; estudio *\*Salud Mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemia\**; OMS, *\*Salud mental del adolescente\**.

---

## ## 2. Datos globales y carga de morbilidad

- En todo el mundo, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece algún tipo de trastorno mental, lo que representa el 15 % de la carga mundial de morbilidad para este grupo etario.
- La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran entre las principales causas de enfermedad y discapacidad en los adolescentes.
- El suicidio es la tercera causa de defunción en las personas de 15 a 29 años.
- Cuando un trastorno de salud mental de un adolescente no se trata, sus consecuencias se extienden a la edad adulta, perjudican la salud física y mental de la persona y limitan sus posibilidades de llevar una vida plena en el futuro.
- En 2021, casi una de cada siete personas (1100 millones) a escala mundial tenía un trastorno mental. Los más habituales son la ansiedad y los trastornos depresivos.
- Aunque existen opciones eficaces de prevención y tratamiento, la mayoría de las personas con trastornos mentales no tienen acceso a una atención eficaz. Además, muchas son víctimas de estigmatización, discriminación y violaciones de los derechos humanos.
- **\*\*Conductas de riesgo:\*\***
  - Muchas conductas de riesgo, como el consumo de sustancias o las prácticas sexuales no seguras, se inician en la adolescencia. Pueden ser mecanismos para hacer frente al malestar emocional y afectar muy negativamente al bienestar físico y mental.
  - Los jóvenes tienen más tendencia a adoptar hábitos nocivos de consumo de sustancias que pueden perdurar a lo largo de la vida.
  - En 2019, la prevalencia del consumo de alcohol entre las personas de 15 a 19 años era elevada en todo el mundo (22 %), con muy pocas diferencias por razones de género, y en algunas regiones se observaba un aumento.
  - El consumo de tabaco y de cannabis son motivos de preocupación adicionales. Muchos fumadores adultos adquirieron el hábito antes de los 18 años.
  - En el caso del cannabis, la prevalencia mundial del consumo entre los adolescentes fue, en 2022, superior a la de los adultos: 5,5 % frente a 4,4 %, respectivamente.
  - Algunos adolescentes incurrir en actos violentos que pueden afectar al rendimiento académico, causarles lesiones y empujarles a la delincuencia y a situaciones de riesgo para sus vidas. En 2021, la violencia interpersonal se clasificó dentro de las causas principales de muerte entre los adolescentes de mayor edad.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, *\*Salud mental del adolescente\**; OMS, *\*Trastornos mentales\**.

---

### ## 3. Trastornos mentales: definición, factores y sistemas de salud

- Los trastornos mentales se caracterizan por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, van asociados a angustia o a discapacidad funcional en ámbitos importantes.
- Hay muchos tipos diferentes de trastornos mentales. También se denominan afecciones de salud mental, aunque este último término es más amplio y abarca los trastornos mentales, las discapacidades psicosociales y otros estados mentales asociados a una angustia considerable, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva.
- Esta información se centra en los trastornos mentales según la Undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11).
- **\*\*Factores de riesgo y protección:\*\*** existe un conjunto diverso de factores individuales, familiares, comunitarios y estructurales que, en conjunto, protegen o socavan la salud mental. Aunque la mayoría de las personas son resilientes, quienes están expuestos a circunstancias adversas —pobreza, violencia, discapacidad y desigualdad— corren un mayor riesgo.
- Entre los factores de protección y de riesgo se cuentan factores psicológicos y biológicos individuales, como las habilidades emocionales y la genética. Muchos de esos factores se ven influidos por cambios en la estructura o la actividad del cerebro.
- **\*\*Sistemas de salud y apoyo social:\*\*** los sistemas de salud aún no han respondido adecuadamente a las necesidades de las personas que padecen trastornos mentales y no cuentan con los recursos necesarios. Hay una divergencia considerable en todo el mundo entre la necesidad de tratamiento y su prestación, que, cuando se da, suele ser de mala calidad.
- Por ejemplo, solo el 29 % de las personas con psicosis y solo un tercio de las personas con depresión reciben atención de salud mental en un sistema formal.
- Las personas con trastornos mentales también requieren apoyo social, en particular para establecer y mantener relaciones personales, familiares y sociales. También pueden necesitar apoyo en programas educativos, empleo, vivienda y participación en otras actividades significativas.

**\*\*Fuente:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*.

---

### ## 4. Trastornos de ansiedad

#### ### 4.1 Generalidades, datos, síntomas y tipos

- Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes del mundo: en 2021 afectaron a 359 millones de personas, incluidos 72 millones de niños y adolescentes.
- Afectan más a las mujeres que a los hombres.
- Sus síntomas suelen aparecer durante la infancia o la adolescencia.
- Existen tratamientos muy eficaces para este tipo de trastornos.

- Aproximadamente una de cada cuatro personas con un trastorno de ansiedad (27,6 %) recibe tratamiento para esa afección.

- Se calcula que un 4,4 % de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad.

- Entre los obstáculos a la atención figuran:

- la falta de concienciación de que el problema es una afección de salud que puede tratarse,

- la falta de inversión en servicios de salud mental,

- la falta de proveedores de atención de salud capacitados,

- el estigma social.

- Todo el mundo puede sentir ansiedad alguna vez, pero las personas con trastornos de ansiedad suelen experimentar miedo y preocupación de manera intensa y excesiva. Estos sentimientos suelen ir acompañados de tensión física y otros síntomas conductuales y cognitivos.

- Son difíciles de controlar, causan una angustia importante y pueden durar mucho tiempo si no se tratan.

- Los trastornos de ansiedad interfieren en las actividades de la vida cotidiana y pueden deteriorar la vida familiar, social y escolar o laboral de una persona.

- Las personas con un trastorno de ansiedad pueden experimentar un miedo o una preocupación excesivos ante una situación específica (como una crisis de angustia o una situación social) o, en el caso del trastorno de ansiedad generalizada, ante una amplia gama de situaciones cotidianas.

- Por lo general, padecen estos síntomas durante un período prolongado, al menos varios meses, y tienden a evitar las situaciones que les generan ansiedad.

- Otros síntomas de los trastornos de ansiedad son:

- dificultad para concentrarse o tomar decisiones,

- irritabilidad, tensión o inquietud,

- náuseas o malestar abdominal,

- palpitaciones,

- sudoración, tiritones o temblores,

- trastornos del sueño,

- sensación de peligro inminente, de pánico o de fatalidad.

- Los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de depresión y de trastornos por consumo de drogas, así como el riesgo de pensamientos y comportamientos suicidas.

- **\*\*Tipos de trastornos de ansiedad:\*\***

- trastorno de ansiedad generalizada (preocupación persistente y excesiva por las actividades o eventos cotidianos);

- trastorno de angustia o pánico (crisis de angustia y miedo a que sigan produciéndose);

- trastorno de ansiedad social (altos niveles de miedo y preocupación por situaciones sociales en las que la persona puede sentirse humillada, avergonzada o rechazada);

- agorafobia (miedo excesivo, preocupación y evitación de situaciones que pueden hacer a alguien entrar en pánico o sentirse atrapado, indefenso o avergonzado);

- trastorno de ansiedad por separación (miedo o preocupación excesivos por estar separado de las personas con las que se tiene un vínculo emocional estrecho);

- determinadas fobias (miedos intensos e irracionales a objetos o situaciones concretos que llevan a conductas de evitación y angustia considerable);
- mutismo selectivo (incapacidad constante para hablar en ciertas situaciones sociales, a pesar de la capacidad de hablar cómodamente en otros entornos; afecta principalmente a los niños).
- Las personas pueden experimentar varios trastornos de ansiedad al mismo tiempo. Por lo general, los síntomas comienzan durante la infancia o la adolescencia y se extienden hasta la edad adulta. Las niñas y las mujeres tienen más probabilidades de sufrir trastornos de ansiedad que los niños y los hombres.
- **\*\*Causas concomitantes y prevención:\*\*** los trastornos de ansiedad, al igual que otras afecciones de salud mental, son el resultado de una compleja interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos. Cualquier persona puede tener un trastorno de ansiedad, pero las personas que han sufrido abusos, pérdidas importantes u otras experiencias adversas tienen más probabilidades de presentarlo.
- Los trastornos de ansiedad están estrechamente relacionados con la salud física y, por consiguiente, esta influye en ellos. Muchos de los efectos de la ansiedad (como la tensión física, la hiperactividad del sistema nervioso o el consumo nocivo de bebidas alcohólicas) son también factores de riesgo conocidos en determinadas enfermedades, como las cardiovasculares. A su vez, las personas con estas enfermedades también pueden sufrir trastornos de ansiedad por las dificultades asociadas con el manejo de su afección.
- Entre las estrategias comunitarias eficaces para prevenir la ansiedad se encuentran la formación para los progenitores y los programas escolares para promover un aprendizaje social y emocional y para crear mecanismos de afrontamiento positivo en los niños y adolescentes. Los programas basados en el ejercicio físico también pueden ser eficaces para prevenir trastornos de ansiedad en los adultos.
- **\*\*Estrés normal vs. trastorno de ansiedad:\*\*** la vida puede ser estresante. Una persona puede sentirse estresada debido a un trabajo exigente, por su rendimiento en la escuela o por un cambio en la vida. Todas las personas sienten estrés de vez en cuando.
- El estrés es la respuesta física o mental a una causa externa, como tener muchos deberes escolares o una enfermedad. Un factor estresante puede ocurrir una sola vez o a corto plazo, o puede suceder de forma repetida durante mucho tiempo.
- La ansiedad es la reacción del cuerpo al estrés y puede ocurrir aunque no exista ninguna amenaza actual.
- Si bien es normal tener estrés y ansiedad de vez en cuando, estos no deberían controlar la vida. Si la ansiedad no desaparece y empieza a interferir con las actividades cotidianas, es posible que se tenga un trastorno de ansiedad. Esta distinción aplica al trastorno de ansiedad generalizada, al trastorno de ansiedad social y al trastorno de pánico.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Trastornos de ansiedad\*; NIMH, publicaciones en español.

---

#### ### 4.2 Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)

- La ansiedad ocasional es parte normal de la vida. Muchas personas se preocupan por cosas como la salud, el dinero, la escuela, el trabajo o la familia.
- Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad generalizada se preocupan extremadamente o se sienten muy nerviosas con mayor frecuencia por estas y otras cosas, incluso cuando la preocupación es desproporcionada con respecto a la situación.
- Por lo general, este trastorno incluye una sensación persistente de ansiedad o pavor que interfiere en la forma en que la persona lleva su vida. No es lo mismo que preocuparse de vez en cuando por las cosas o

sentirse ansioso debido a eventos estresantes en la vida. Las personas que tienen este trastorno sienten ansiedad durante meses y hasta años.

- El trastorno de ansiedad generalizada se desarrolla lentamente. A menudo comienza durante la adultez temprana, aunque también puede ocurrir a cualquier edad. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de tener este trastorno y algunas mujeres lo tienen durante el embarazo o el período de posparto.

- Con el apoyo y el tratamiento adecuado, las personas con este trastorno pueden controlar su ansiedad y mejorar su calidad de vida.

- **\*\*Signos y síntomas:\*\*** las personas con TAG pueden:

- preocuparse demasiado por las cosas diarias;
- tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo;
- sentirse irritables o con los nervios de punta frecuentemente;
- sentirse inquietas o tener dificultad para relajarse;
- tener problemas para concentrarse;
- tener problemas para dormir o para permanecer dormidas, o sentirse agotadas;
- tener dolores de cabeza, musculares o estomacales, tensión u otros dolores;
- tener temblores o tics (movimientos nerviosos);
- sudar mucho, sentirse mareadas o que les falta el aire;
- tener dificultad para tragar;
- tener que ir al baño a menudo.

- Con frecuencia, los adultos con este trastorno se ponen sumamente nerviosos por situaciones diarias como:

- la seguridad laboral o su rendimiento en el trabajo;
- su salud;
- las finanzas;
- la salud y el bienestar de sus hijos y de otros familiares;
- llegar tarde;
- completar las tareas del hogar y cumplir con otras responsabilidades.

- Los niños y los adolescentes con TAG pueden preocuparse por muchas de las mismas cosas que los adultos, pero sus inquietudes suelen centrarse en la escuela, las actividades extracurriculares, sus amigos y el futuro. Pueden tener dificultades con la incertidumbre y el temor de cometer errores, o preocuparse por decepcionar a los demás. Es posible que se esfuercen por alcanzar la perfección como una forma de controlar la ansiedad.

- Para todas las personas con TAG, los síntomas pueden fluctuar con el tiempo y a menudo empeoran durante momentos de estrés, como una enfermedad física, épocas de exámenes escolares o durante un conflicto familiar o de relaciones personales.

- **\*\*Causas:\*\*** el TAG puede ser hereditario, pero aún no se sabe cuál es la causa exacta. Diversas investigaciones sugieren que este trastorno es provocado por una combinación de la genética, la química del cerebro, la biología y el entorno. Los investigadores han descubierto que las causas externas, como pasar por un evento traumático o estar en un ambiente estresante, pueden aumentar el riesgo de llegar a tener TAG.

- **\*\*Diagnóstico:\*\*** para que le diagnostiquen TAG, una persona debe tener dificultades para controlar sus preocupaciones casi todos los días durante al menos seis meses. La persona también debe tener al menos tres de estos síntomas: sentirse inquieta o con los nervios de punta, sentirse agotada, tener problemas para concentrarse, sentirse irritable, tener tensión muscular o tener problemas para dormir.

- Si se cree que se tienen síntomas de TAG, se debe hablar con un proveedor de atención médica, como un médico de atención primaria, un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social clínico. Durante la consulta, podrían preguntar cuándo empezaron los síntomas, cuánto tiempo han durado, con qué frecuencia ocurren y qué impacto tienen en la vida. Después de analizar los antecedentes, el proveedor puede realizar un examen físico para asegurarse de que un problema físico no relacionado no esté provocando los síntomas.

- **\*\*Comorbilidades:\*\*** algunas personas con TAG tienen otras afecciones o trastornos mentales y físicos, como depresión, otros trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, síndromes de dolor crónico, problemas cardiovasculares, pensamientos o comportamientos suicidas. Con frecuencia, el TAG también se asocia al consumo indebido de alcohol y otras sustancias.

- La existencia de varios trastornos puede hacer que el tratamiento sea más complejo, y las personas con TAG y otros trastornos mentales concurrentes podrían beneficiarse de un plan de tratamiento integral que aborde todos los aspectos de su salud mental.

- **\*\*Tratamiento específico:\*\*** además de lo descrito en el apartado común de tratamiento de ansiedad, para el TAG se considera la buspirona. La buspirona es otro medicamento contra la ansiedad que puede ser útil. A diferencia de las benzodiazepinas, no es un sedante y es menos probable que sea adictivo. La buspirona debe tomarse durante tres a cuatro semanas para que sea completamente efectiva.

**\*\*Fuente:\*\*** NIMH, publicaciones en español.

---

### ### 4.3 Trastorno de ansiedad social

- Es un tipo frecuente de trastorno de ansiedad. Una persona con trastorno de ansiedad social siente síntomas de ansiedad o temor en situaciones en las que otros pueden estar analizándola, evaluándola o juzgándola, como:

- hablar en público,
- conocer gente nueva,
- salir con alguien en una cita,
- asistir a una entrevista de trabajo,
- responder una pregunta en clase,
- pedir ayuda,
- tener que hablar con un cajero en una tienda.

- Hacer cosas rutinarias, como comer o beber frente a otras personas o usar un baño público, también puede causar ansiedad o temor debido a la preocupación de que la humillen, la juzguen o la rechacen.

- A menudo, se siente que este temor es incontrolable y puede interferir en la vida cotidiana. Las personas con trastorno de ansiedad social pueden preocuparse por tener que participar en alguna situación social desde semanas antes de que estas se lleven a cabo. A veces, terminan por evitar ir a lugares o eventos que les causan angustia o les generan sentimientos de vergüenza.



- En algunos casos, la ansiedad puede ocurrir en situaciones cuando deben hacer algo delante de otros, como dar un discurso, competir en un juego deportivo o tocar un instrumento musical en el escenario.

- Por lo general, el trastorno de ansiedad social comienza durante la infancia o la adolescencia y puede parecer que la persona tiene timidez extrema o que evita situaciones públicas o interacciones sociales. El trastorno ocurre con más frecuencia en las mujeres que en los hombres y esta diferencia es más pronunciada en los adolescentes y los adultos jóvenes.

- Con el tratamiento adecuado y con apoyo, las personas con este trastorno pueden controlar su ansiedad y mejorar su calidad de vida.

- **\*\*Signos y síntomas:\*\*** cuando deben hacer algo delante de los demás o están rodeadas de otros, las personas con trastorno de ansiedad social pueden:

- enrojecerse, sudar o temblar;
- tener una frecuencia cardíaca rápida;
- sentir que su “mente se pone en blanco” o tener malestar estomacal;
- mostrar una postura corporal rígida o hablar con una voz sumamente baja;
- tener dificultad para hacer contacto visual, estar con personas que no conocen o hablar en situaciones sociales aun cuando quieran hacerlo;
- sentirse inseguras de sí mismas o temer que se les juzgue negativamente;
- evitar lugares donde hay otras personas o situaciones en las que podrían tener que interactuar con otros;
- analizar sus acciones e identificar fallas autopercebidas en sus interacciones;
- esperar las peores consecuencias posibles de una situación social negativa.

- Los niños y los adolescentes con trastorno de ansiedad social pueden tener síntomas similares a los de los adultos, pero también pueden:

- intentar evitar ir a la escuela,
- tener dificultades para hacer amigos,
- quejarse de dolores de estómago o de cabeza,
- tener arrebatos emocionales en situaciones sociales,
- negarse a hablar o a participar en situaciones sociales.

- En todas las personas con trastorno de ansiedad social, los síntomas pueden fluctuar con el tiempo y a menudo empeoran en momentos de estrés o cambios significativos. Evitar situaciones que provocan ansiedad puede ser útil a corto plazo, pero es probable que sin tratamiento la ansiedad permanezca.

- **\*\*Causas:\*\*** el trastorno de ansiedad social puede ser hereditario, pero nadie sabe con seguridad por qué algunos miembros de la familia lo tienen y otros no. Los investigadores han descubierto que varias partes del cerebro desempeñan cierto papel en el temor y la ansiedad, y que la genética influye en la forma en que funcionan estas áreas. También se está explorando si el estrés y los factores ambientales pueden desempeñar algún papel.

- **\*\*Diagnóstico:\*\*** para que le diagnostiquen trastorno de ansiedad social, una persona debe sentir un fuerte temor o ansiedad frente a situaciones en las que otros podrían juzgarla o analizarla. La persona puede intentar evitar estas situaciones o enfrentarlas con una incomodidad extrema. Estos sentimientos deben durar al menos seis meses e interferir en la vida cotidiana, como el trabajo, la escuela o las relaciones.

- Si se cree que se tienen síntomas, se debe hablar con un proveedor de atención médica, como un médico de atención primaria, un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social clínico. Durante la consulta, podrían preguntar cuándo empezaron los síntomas, cuánto tiempo han durado, con qué frecuencia ocurren

y qué impacto tienen en la vida. Después de analizar los antecedentes, el proveedor puede realizar un examen físico para asegurarse de que un problema físico no relacionado no esté provocando los síntomas.

- **\*\*Comorbilidades:\*\*** algunas personas con trastorno de ansiedad social tienen otras afecciones o trastornos mentales y físicos, como depresión, otros trastornos de ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, trastorno dismórfico corporal o trastorno bipolar. Con frecuencia, también se asocia al consumo indebido de alcohol y otras sustancias.

- Es menos probable que las personas con trastorno de ansiedad social busquen la ayuda de un proveedor de atención médica para su diagnóstico o tratamiento. A menudo, los proveedores identifican este trastorno cuando tratan a una persona por una enfermedad coexistente.

- La existencia de varios trastornos puede hacer que el tratamiento sea más complejo, y las personas con trastorno de ansiedad social y otros trastornos mentales concurrentes podrían beneficiarse de un plan de tratamiento integral que aborde todos los aspectos de su salud mental.

- **\*\*Tratamiento específico:\*\*** además de lo descrito en el apartado común de tratamiento de ansiedad, se usan betabloqueadores (también conocidos como betabloqueantes). Pueden ayudar a controlar algunos de los síntomas físicos del trastorno de ansiedad social, como la frecuencia cardíaca rápida, la sudoración y los temblores. Por lo general, son el medicamento de preferencia para el tipo de trastorno de ansiedad social conocido como “ansiedad de rendimiento”.

- **\*\*Grupos de apoyo específicos:\*\*** en un grupo de personas en que todas tienen el trastorno de ansiedad social, una persona puede escuchar comentarios imparciales y honestos sobre cómo la ven los demás. Esto le permite descubrir que sus pensamientos de que otros la juzgan o la rechazan no son ciertos o están distorsionados. También puede aprender cómo otros con trastorno de ansiedad social abordan y superan el temor a las situaciones sociales.

**\*\*Fuente:\*\*** NIMH, publicaciones en español.

---

#### ### 4.4 Trastorno de pánico

- Las personas con trastorno de pánico tienen ataques frecuentes e inesperados. Estos ataques se caracterizan por una ola repentina de temor o incomodidad, o bien una sensación de perder el control, incluso cuando no hay un peligro real o un factor desencadenante claro.

- No todas las personas que tienen un ataque de pánico llegarán a tener este trastorno.

- A menudo, los ataques de pánico incluyen síntomas físicos como temblores, hormigueo en el cuerpo o latidos rápidos, que podrían sentirse como si le estuviera dando un ataque al corazón. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento, incluso mientras duermen.

- Muchas personas con este trastorno se preocupan por la posibilidad de tener otro ataque y podrían hacer cambios considerables en sus vidas para evitarlo.

- Los ataques de pánico pueden ocurrir con tanta frecuencia como varias veces al día, o tan poco como unas cuantas veces al año.

- A menudo, el trastorno de pánico comienza a final de la adolescencia o a principios de la edad adulta. Las mujeres tienen una mayor probabilidad que los hombres de llegar a tener este trastorno.

- Con el tratamiento y el apoyo adecuados, las personas con trastorno de pánico pueden controlar los síntomas y mejorar su calidad de vida.

- **\*\*Signos y síntomas:\*\*** las personas con trastorno de pánico pueden tener:

- ataques de pánico repentinos y repetidos con ansiedad y miedo abrumadores;
  - una sensación de estar fuera de control;
  - miedo a la muerte o a una fatalidad inminente durante un ataque de pánico;
  - una preocupación intensa sobre cuándo ocurrirá el próximo ataque de pánico;
  - temor de ir o evitar ir a los lugares donde han tenido un ataque de pánico en el pasado.
- Los síntomas físicos durante un ataque de pánico pueden incluir:
- latidos fuertes o rápidos del corazón,
  - sudor,
  - escalofríos,
  - temblores,
  - dificultad para respirar,
  - debilidad o mareos,
  - hormigueo o entumecimiento de las manos,
  - dolor en el pecho,
  - dolor de estómago o náuseas.
- Un ataque de pánico puede durar desde unos minutos hasta una hora, o a veces más. Aunque estos sentimientos pueden ser angustiosos, los ataques de pánico en sí no ponen en peligro la vida y los síntomas físicos suelen desaparecer con el tiempo. Sin embargo, para algunas personas, el temor a tener futuros ataques puede provocar una ansiedad continua.
- **\*\*Diferencia entre ataque de pánico y trastorno de pánico:\*\*** un ataque de pánico es un episodio que ocurre una sola vez u ocasionalmente y que provoca temor intenso y síntomas físicos y emocionales. Un ataque de pánico aislado no es un trastorno mental. El trastorno de pánico puede diagnosticarse cuando una persona tiene ataques de pánico repentinos y frecuentes, junto con una preocupación constante o cambios en el comportamiento debido al temor de sufrir ataques en el futuro, lo que suele interferir con su vida cotidiana.
- **\*\*Causas:\*\*** a veces, el trastorno de pánico podría ser hereditario, pero nadie sabe con seguridad por qué algunos miembros de una familia lo tienen y otros no. Los investigadores han descubierto que varias partes del cerebro y ciertos procesos biológicos pueden desempeñar un papel fundamental en el temor y la ansiedad. Algunos investigadores consideran que los ataques de pánico son como una “falsa alarma” en la que los instintos normales de sobrevivencia del cuerpo están activos con demasiada frecuencia o fuerza, o una combinación de ambas.
- Por ejemplo, una persona con trastorno de pánico podría sentir palpitaciones fuertes y asumir que está teniendo un ataque al corazón. Esto puede dar origen a un círculo vicioso, ocasionando que una persona tenga ataques de pánico aparentemente de improviso, que es la característica principal del trastorno de pánico. También se está explorando cómo el estrés y los factores ambientales desempeñan algún papel.
- **\*\*Diagnóstico:\*\*** para que le diagnostiquen trastorno de pánico, una persona debe tener ataques de pánico repentinos y frecuentes. También debe pasar durante al menos un mes preocupándose de que tendrá más ataques, sintiendo miedo de lo que significan estos ataques o modificando su comportamiento para intentar evitar futuros ataques.
- Si se cree que se tienen síntomas, se debe hablar con un proveedor de atención médica, como un médico de atención primaria, un psiquiatra, un psicólogo o un trabajador social clínico. Durante la consulta, podrían preguntar cuándo empezaron los síntomas, cuánto tiempo han durado, con qué frecuencia ocurren y qué impacto tienen en la vida. Después de analizar los antecedentes, el proveedor puede realizar un examen físico para asegurarse de que un problema físico no relacionado no esté provocando los síntomas.

- **\*\*Comorbilidades:\*\*** algunas personas con trastorno de pánico tienen otras afecciones o trastornos mentales y físicos, como depresión, otros trastornos de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, enfermedad cardiovascular, trastornos respiratorios, síndrome del intestino irritable o problemas de tiroides. Con frecuencia, también se asocia al consumo indebido de alcohol y otras sustancias.

- A veces, se puede tener agorafobia de forma concurrente con el trastorno de pánico. Las personas con agorafobia tienen ansiedad o un miedo intenso a ciertos lugares o situaciones en los que escapar u obtener ayuda podría ser difícil o no estar disponible si tienen un ataque de pánico o síntomas similares al pánico.

- La existencia de varios trastornos puede hacer que el tratamiento sea más complejo, y las personas con trastorno de pánico y otros trastornos mentales concurrentes podrían beneficiarse de un plan de tratamiento integral que aborde todos los aspectos de su salud mental.

- **\*\*Tratamiento específico:\*\*** además de lo descrito en el apartado común de tratamiento de ansiedad, se emplea la exposición interoceptiva, una técnica de la terapia cognitivo-conductual que consiste en la exposición a sensaciones corporales asociadas con los ataques de pánico y los síntomas del trastorno de pánico. La terapia de exposición se puede utilizar junto con ejercicios de relajación y técnicas de respiración.

- Los betabloqueadores pueden ayudar a controlar algunos de los síntomas físicos del trastorno de pánico, como la frecuencia cardíaca rápida, la sudoración y los temblores. Aunque los proveedores de atención médica no suelen recetarlos para este trastorno, el medicamento puede ser útil en ciertas situaciones que preceden a un ataque de pánico.

**\*\*Fuente:\*\*** NIMH, publicaciones en español.

---

#### ### 4.5 Tratamiento, cuidado personal, apoyo y recursos para ansiedad

- **\*\*Diagnóstico y tratamiento general:\*\*** existen diversos tratamientos eficaces. Las personas con síntomas de ansiedad deberían buscar atención médica.

- Las intervenciones psicológicas son tratamientos esenciales de los trastornos de ansiedad y consisten principalmente en terapias conversacionales con profesionales o con terapeutas no especializados pero supervisados. Estas intervenciones pueden ayudar a aprender nuevas formas de concebir la ansiedad, hacerle frente y relacionarse tanto con la ansiedad como con las demás personas y con el mundo. De ese modo, pueden enseñar cómo enfrentarse a situaciones, eventos, personas o lugares que provocan ansiedad.

- Las intervenciones psicológicas pueden ofrecerse a individuos o grupos, presencialmente o en línea. También puede accederse a ellas a través de manuales de autoayuda, sitios web y aplicaciones.

- Las intervenciones psicológicas más avaladas por las pruebas para el tratamiento de diversos trastornos de ansiedad son las que se basan en los principios de la terapia cognitivo-conductual. Entre ellas figura la terapia de exposición, en la que la persona aprende a enfrentarse a sus miedos.

- La terapia cognitivo-conductual ha sido muy bien estudiada y es el método de referencia para la psicoterapia. Ayuda a las personas a estar más atentas a sus formas automáticas de pensar que son incorrectas o perjudiciales y posteriormente a cuestionar esos pensamientos, comprender cómo afectan sus emociones y comportamientos, y cambiar los patrones de conductas autodestructivas.

- Otra opción de tratamiento para el TAG y la ansiedad social es la terapia de aceptación y compromiso. Fomenta una aceptación de los pensamientos y los comportamientos sin juzgarlos, y promueve la participación en actividades significativas. Utiliza estrategias como la atención plena y el establecimiento

de metas para reducir la incomodidad y la ansiedad. Hay un creciente conjunto de investigaciones que demuestran su eficacia.

- Además, aprender habilidades para gestionar el estrés, como las relacionadas con la relajación y la atención plena (mindfulness), puede ayudar a reducir los síntomas.

#### - **\*\*Medicamentos:\*\***

- Los médicos y otros proveedores de atención médica pueden recetar medicamentos para tratar los trastornos de ansiedad.

- Los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) y los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina (IRSN), pueden ser eficaces. Con frecuencia se usan para tratar la depresión, pero también pueden ayudar con los síntomas de ansiedad.

- Estos medicamentos pueden tardar varias semanas para que empiecen a funcionar y pueden causar efectos secundarios, como dolores de cabeza, náuseas o dificultad para dormir. Por lo general, estos efectos secundarios no son graves para la mayoría de las personas, en especial si se comienza con una dosis baja y se va aumentando lentamente.

- Los proveedores deben tener presentes los posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a cabo uno u otro tipo de intervención y las preferencias individuales.

- Los ansiolíticos o medicamentos contra la ansiedad incluyen las benzodiazepinas y la buspirona.

- Las benzodiazepinas, que son un tipo de sedantes contra la ansiedad, pueden usarse para ayudar a controlar tipos graves de ansiedad. Pueden ser muy eficaces para disminuir rápidamente la ansiedad, pero algunas personas desarrollan una tolerancia y necesitan dosis cada vez más altas para obtener el mismo efecto. Algunas personas incluso se vuelven dependientes, por lo que el proveedor quizás las recete solo por breves períodos de tiempo. Históricamente se han recetado para los trastornos de ansiedad, pero han dejado de recomendarse por su alto potencial de dependencia y su limitada eficacia a largo plazo.

- La buspirona no es un sedante y es menos probable que sea adictivo. Debe tomarse durante tres a cuatro semanas para que sea completamente efectiva.

- Los betabloqueadores pueden ayudar a controlar síntomas físicos; en ansiedad social se prefieren para la “ansiedad de rendimiento”; en pánico no suelen recetarse, pero pueden ser útiles en ciertas situaciones que preceden a un ataque.

- **\*\*Grupos de apoyo:\*\*** a algunas personas con trastornos de ansiedad les beneficia participar en grupos de autoayuda o de apoyo, y compartir sus problemas y sus logros con otros. Los grupos de apoyo están disponibles tanto en persona como en línea. Sin embargo, cualquier consejo que reciba de un miembro de algún grupo de apoyo debe usarse con cautela y no reemplaza las recomendaciones de tratamiento de un proveedor de atención médica.

- **\*\*Hábitos saludables:\*\*** practicar un estilo de vida saludable también puede ayudar a combatir la ansiedad, aunque esto por sí solo no puede sustituir el tratamiento. Los investigadores han descubierto que escoger ciertas opciones saludables en la vida diaria, como reducir el consumo de cafeína y dormir lo suficiente, puede reducir los síntomas de ansiedad cuando se combina con una atención estándar, como la psicoterapia y los medicamentos.

- Las técnicas para el control del estrés, como el ejercicio, la atención plena y la meditación, también pueden reducir los síntomas de ansiedad e intensificar los efectos de la psicoterapia.

#### - **\*\*Cuidado personal para ansiedad:\*\***

- evitar o reducir el consumo de bebidas alcohólicas y no tomar drogas, ya que pueden empeorar la ansiedad;

- hacer ejercicio a menudo, aunque solo sea dar un paseo;

- seguir, en la medida de lo posible, unos hábitos alimenticios y de sueño regulares, y llevar una dieta sana;

- aprender técnicas de relajación, como la respiración lenta y la relajación muscular progresiva;
- desarrollar el hábito de la meditación de atención plena, aunque solo sean unos minutos al día.
- **\*\*Apoyo a uno mismo o a otras personas con ansiedad:\*\***
  - **\*\*Eduquese:\*\*** buscar información sobre signos, síntomas, opciones de tratamiento y mantenerse actualizado con las investigaciones.
  - **\*\*Hable con honestidad:\*\*** si tiene síntomas, hable honestamente sobre cómo se siente con alguien en quien confíe. Si cree que un amigo o familiar puede estar luchando, dedique tiempo para hablar con ellos, expresarles su preocupación y hacerles saber que tienen su apoyo.
  - **\*\*Sepa cuándo buscar ayuda:\*\*** si la ansiedad comienza a causar problemas en la vida cotidiana, como en la escuela, el trabajo o con amigos y familiares, es momento de buscar ayuda profesional.
  - **\*\*Tenga compasión:\*\*** sea amable y paciente consigo mismo y con los demás. Reconozca los avances, por pequeños que sean, y reconozca que controlar el trastorno puede incluir contratiempos en el proceso.
  - **\*\*Cómo encontrar ayuda:\*\*** si preocupa la salud mental, hable con un médico u otro proveedor de atención médica. Ellos pueden referirlo a un profesional apto de salud mental, como un psicólogo, un psiquiatra o un trabajador social clínico. También se puede consultar el sitio web del NIMH y el de la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA).
- Si usted o alguien que conoce está pasando dificultades o tiene pensamientos suicidas, llame o envíe un mensaje de texto al 988, la Línea de Prevención del Suicidio y Crisis. También puede obtener apoyo a través de su chat en vivo en 988lifeline.org. En situaciones potencialmente mortales, llame al 911.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Trastornos de ansiedad\*; NIMH, publicaciones en español.

---

## ## 5. Depresión

### ### 5.1 Generalidades, datos, síntomas y tipos

- La depresión es un trastorno mental común. Se estima que, en todo el mundo, el 5,7 % de los adultos padecen depresión.
- La depresión afecta más a la mujer que al hombre.
- La depresión puede llevar al suicidio.
- Hay tratamientos eficaces para la depresión, ya sea leve, moderada o grave.
- El trastorno depresivo (o depresión) implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o el interés por actividades durante largos períodos de tiempo.
- La depresión es distinta de los cambios habituales en el estado de ánimo y en los sentimientos sobre el día a día. Puede afectar a todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistad y las comunitarias. Puede deberse a problemas en la escuela y laborales o causarlos.
- La depresión puede afectar a cualquiera. Quienes han vivido abusos, pérdidas graves u otros eventos estresantes tienen más probabilidades de sufrirla. Las mujeres son más propensas que los hombres.

- Se estima que el 4,0 % de la población experimenta depresión, incluido el 5,7 % de los adultos (4,6 % entre los hombres y 6,9 % entre las mujeres) y el 5,9 % de los adultos de 70 años o más.
- A escala mundial, aproximadamente 332 millones de personas sufren depresión.
- La depresión es aproximadamente 1,5 veces más frecuente entre las mujeres que entre los hombres.
- En todo el mundo, más del 10 % de las mujeres embarazadas y de las que acaban de dar a luz experimentan depresión.
- En los países de ingreso alto, solamente un tercio de las personas que padecen depresión reciben cuidados de salud mental.
- Entre los obstáculos a una atención eficaz cabe destacar la falta de inversión en atención de salud mental, la falta de proveedores de atención de salud capacitados y la estigmatización a nivel social asociada a los trastornos mentales.
- En 2019, 280 millones de personas tenían depresión, entre ellos 23 millones de niños y adolescentes.
- **\*\*Síntomas y tipologías:\*\***
  - En un episodio depresivo, la persona experimenta un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del placer o del interés por actividades.
  - Un episodio depresivo es distinto de las variaciones habituales del estado de ánimo. Estos episodios abarcan la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos dos semanas.
  - Pueden presentarse varios síntomas más, como:
    - dificultades para concentrarse,
    - un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima,
    - falta de esperanza acerca del futuro,
    - pensamientos de muerte o suicidio,
    - alteraciones del sueño,
    - cambios en el apetito o en el peso,
    - sensación de cansancio acusado o de falta de energía.
  - La depresión puede causar dificultades en todos los aspectos de la vida, incluidas la vida comunitaria y en el hogar, así como en el trabajo y la escuela.
  - Los episodios depresivos pueden clasificarse en leves, moderados o graves, en función del número y la intensidad de los síntomas, así como de las repercusiones en el funcionamiento de la persona.
  - Los episodios depresivos pueden pertenecer a diferentes tipologías:
    - trastorno depresivo de un solo episodio: la persona experimenta un primer y único episodio;
    - trastorno depresivo recurrente: la persona ha padecido ya al menos dos episodios depresivos;
    - trastorno bipolar: los episodios depresivos alternan con períodos de episodios maníacos, que incluyen euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía, y otros síntomas como aumento de la verborrea, pensamientos acelerados, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente.
- **\*\*Causas concomitantes y prevención:\*\*** la depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias vitales adversas (desempleo, luto, eventos traumáticos) tienen más probabilidades de sufrir depresión. A su vez, la depresión puede generar más estrés y disfunción, y empeorar la situación vital de la persona afectada y, por consiguiente, la propia depresión.

- La depresión está estrechamente relacionada con la salud física y, por consiguiente, la salud física desempeña un papel en la depresión. Muchos de los factores que influyen en la depresión (como la inactividad física o el consumo nocivo del alcohol) también son factores de riesgo conocidos para enfermedades como las cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades respiratorias. A su vez, las personas con estas enfermedades también pueden estar sufriendo depresión a causa de las dificultades asociadas al manejo de su afección.

- Está demostrado que los programas de prevención reducen la depresión. Entre las estrategias comunitarias eficaces se encuentran los programas escolares para promover un modelo de afrontamiento positivo entre los niños y los adolescentes. Las intervenciones dirigidas a los progenitores de niños con problemas de conducta pueden reducir los síntomas depresivos de los progenitores y mejorar los resultados de sus hijos. Los programas de ejercicio para las personas mayores también pueden ser eficaces para prevenir la depresión.

- **\*\*Diagnóstico y tratamiento:\*\*** hay tratamientos eficaces para la depresión, incluidos los tratamientos psicológicos y la medicación. Se debe buscar cuidados si se presentan síntomas de depresión.

- Los tratamientos psicológicos son el primer tratamiento contra la depresión. Pueden combinarse con antidepresivos en casos de depresión moderada y grave. Los antidepresivos no son necesarios en caso de depresión leve.

- Los tratamientos psicológicos pueden enseñar nuevas maneras de pensar, de hacer frente a las situaciones o de relacionarse con los demás. Pueden incluir terapia conversacional con profesionales y con terapeutas no especializados supervisados. La terapia conversacional puede llevarse a cabo cara a cara o en línea. Puede accederse a tratamientos psicológicos a través de manuales de autoayuda, sitios web y aplicaciones.

- Los tratamientos psicológicos eficaces contra la depresión incluyen:

- la activación conductual,
- la terapia cognitivo-conductual,
- la psicoterapia interpersonal,
- el tratamiento para la resolución de problemas.

- Los antidepresivos incluyen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como la fluoxetina.

- Los proveedores de atención de salud deben tener presentes los posibles efectos adversos de los antidepresivos, las posibilidades de llevar a cabo uno u otro tipo de intervención y las preferencias individuales.

- Los antidepresivos no se deben utilizar para tratar la depresión en niños ni como tratamiento de primera elección en adolescentes, en quienes hay que utilizarlos con suma cautela.

- Para el trastorno bipolar se utilizan diferentes medicamentos y tratamientos.

- **\*\*Nota:\*\*** la depresión y la ansiedad pueden compartir algunos síntomas, como los cambios repentinos e inesperados del estado de ánimo.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Depresión\*; OMS, \*Trastornos mentales\*.

---



- La depresión en adolescentes (entre 13 y 17 años) es una enfermedad médica grave. Es más que sentirse triste durante unos días. Es un intenso sentimiento de tristeza, desesperanza e ira o frustración que dura mucho tiempo.

- Estos sentimientos hacen que sea difícil tener una vida normal y hacer las actividades habituales. También puede haber problemas para concentrarse y no tener motivación o energía. La depresión puede hacer difícil disfrutar la vida o incluso superar el día.

- **\*\*Causas:\*\*** muchos factores pueden jugar un papel en la depresión, incluyendo:

- genética: la depresión puede darse en familias;
- biología cerebral y química;
- hormonas: los cambios hormonales pueden contribuir a la depresión;
- eventos estresantes en la niñez como traumas, muerte de un ser querido, intimidación y ciberacoso; y abuso.

- **\*\*Quiénes están en riesgo:\*\*** la depresión puede ocurrir a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o al comienzo de la adultez. Ciertos adolescentes tienen un mayor riesgo, como quienes:

- tienen otras afecciones de salud mental, como ansiedad, trastornos de la alimentación y uso de sustancias;
- tienen otras enfermedades, como diabetes, cáncer y enfermedades del corazón;
- tienen familiares con enfermedades mentales;
- tienen un conflicto familiar o una familia disfuncional;
- tienen problemas con amigos u otros compañeros en la escuela;
- tienen discapacidades de aprendizaje o trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH);
- han sufrido un trauma en la infancia;
- tienen baja autoestima, una perspectiva pesimista o poca capacidad de enfrentar situaciones.

- **\*\*Síntomas:\*\*** si se tiene depresión, uno o más de estos síntomas se presentarían con frecuencia:

- tristeza,
- sensación de vacío,
- desesperanza,
- sentir enojo, irritación o frustración, incluso por cosas menores.

- También se pueden tener otros síntomas, como:

- no importan las cosas que solían disfrutarse;
- cambios de peso, como perder peso sin estar a dieta o aumentar de peso por comer demasiado;
- cambios en el sueño, como problemas para quedarse o permanecer dormido, o dormir mucho más de lo normal;
- sentirse inquieto o tener problemas para permanecer sentado;
- sentirse muy cansado o no tener energía;
- sentirse sin valor o muy culpable;
- tener problemas para concentrarse, recordar información o tomar decisiones;

- pensar en la muerte o suicidio.
- **\*\*Diagnóstico:\*\*** si se cree que se está deprimido, se debe decir a alguien en quien se confíe, por ejemplo:
  - padres o tutores,
  - maestros o consejeros,
  - médicos.
- El siguiente paso es visitar al médico para un chequeo. El médico puede primero asegurarse de que no hay otro problema de salud que esté causando la depresión. Para hacer esto, es posible que haga un examen físico y pruebas de laboratorio.
- Si no hay otro problema de salud, se obtendrá una evaluación psicológica. El médico puede hacerla o puede referir a un profesional de salud mental. Se pueden hacer preguntas sobre:
  - pensamientos y sentimientos,
  - cómo va en la escuela,
  - cualquier cambio en alimentación, sueño o energía,
  - si se piensa en suicidarse,
  - si se usa alcohol o drogas.

**\*\*Fuente:\*\*** MedlinePlus / NIMH, publicaciones en español.

---

### ### 5.3 Cuidado personal y pensamientos suicidas en depresión

- El cuidado personal puede ser clave en el manejo de los síntomas de la depresión, así como en el fomento del bienestar general.
- **\*\*¿Qué puede hacer?\*\***
  - Trate de seguir haciendo cosas que solía disfrutar.
  - Mantenga el contacto con amigos y familia.
  - Haga ejercicio a menudo, aunque solo sea dar un paseo.
  - Siga, si es posible, unos hábitos alimenticios y de sueño regulares.
  - Evite o reduzca el consumo de alcohol y no tome drogas ilícitas, que pueden empeorar la depresión.
  - Cuente a alguien de confianza cómo se siente.
  - Acuda a un proveedor de atención de salud.
- **\*\*Si tiene pensamientos suicidas:\*\***
  - Recuerde que no está solo, que muchos han pasado por esto y encontraron ayuda.
  - Cuente a alguien de confianza cómo se siente.

- Hable con un trabajador de la salud (un médico o un consejero).
- Únase a un grupo de apoyo.
- Si cree que existe el peligro de que, a corto plazo, pueda hacerse daño, póngase en contacto con un servicio de emergencia o con una línea de atención telefónica para situaciones de crisis.

**\*\*Fuente:\*\* OMS, \*Depresión\*; NIMH.**

---

## ## 6. Otros trastornos mentales

### ### 6.1 Trastorno bipolar

- En 2021, 37 millones de personas tenían trastorno bipolar, entre ellas 3,8 millones de adolescentes entre 10 y 19 años.
- Las personas con trastorno bipolar experimentan episodios depresivos alternados con períodos de síntomas maníacos.
- Durante el episodio depresivo, experimentan un estado de ánimo deprimido (tristeza, irritabilidad, sensación de vacío) o una pérdida del disfrute o del interés en actividades, la mayor parte del día, casi todos los días.
- Los síntomas maníacos pueden incluir euforia o irritabilidad, mayor actividad o energía y otros síntomas, como aumento de la verborrea, pensamientos acelerados, mayor autoestima, menor necesidad de dormir, distracción y comportamiento impulsivo e imprudente.
- Las personas con trastorno bipolar tienen un mayor riesgo de cometer suicidio.
- Existen opciones terapéuticas eficaces, como psicoeducación, reducción del estrés y fortalecimiento del funcionamiento social, y medicación.
- Para el trastorno bipolar se utilizan diferentes medicamentos y tratamientos.

**\*\*Fuente:\*\* OMS, \*Trastornos mentales\*; OMS, \*Depresión\*.**

### ### 6.2 Trastorno de estrés postraumático (TEPT)

- Este trastorno puede desarrollarse después de la exposición a un suceso o serie de sucesos extremadamente amenazantes u horribles.
- Se caracteriza por todo lo siguiente:
  1. volver a experimentar el suceso o sucesos traumáticos en el presente (recuerdos intrusivos, escenas retrospectivas o pesadillas);
  2. evitar pensamientos y recuerdos del suceso o sucesos, o evitar actividades, situaciones o personas que recuerden al suceso o sucesos;

3. percepciones persistentes de una mayor amenaza actual.

- Estos síntomas duran al menos varias semanas y causan una discapacidad funcional importante.
- Existe un tratamiento psicológico eficaz.

**\*\*Fuente:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*.

#### ### 6.3 Esquizofrenia y trastornos psicóticos

- A escala mundial, la esquizofrenia afecta a unos 23 millones de personas, es decir, a una de cada 345 personas.
- Las personas con esquizofrenia tienen una esperanza de vida nueve años inferior a la de la población general.
- La esquizofrenia se caracteriza por una importante deficiencia en la percepción y por cambios de comportamiento.
- Los síntomas pueden incluir persistencia de ideas delirantes, alucinaciones, pensamiento desorganizado, comportamiento muy desorganizado o agitación extrema.
- Las personas con esquizofrenia pueden ver entorpecidas de forma persistente sus capacidades cognitivas.
- Existen diversas opciones terapéuticas eficaces, entre las que se cuentan la medicación, la psicoeducación, las intervenciones familiares y la rehabilitación psicosocial.
- Los trastornos psicóticos suelen aparecer a finales de la adolescencia o principios de la edad adulta y causan síntomas como alucinaciones o delirios. Son experiencias que pueden afectar a la capacidad del adolescente para realizar actividades cotidianas y para el aprendizaje y que, en muchos casos, conducen a la estigmatización o a violaciones de los derechos humanos.
- Un 0,1 % de los adolescentes de 15 a 19 años sufre esquizofrenia.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*; OMS, \*Salud mental del adolescente\*.

#### ### 6.4 Trastornos del comportamiento alimentario

- En 2021, 16 millones de personas tenían trastornos alimentarios, de los que casi 3,4 millones eran niños y adolescentes.
- Los trastornos del comportamiento alimentario, como la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa, se caracterizan por alteraciones en la alimentación y preocupación por los alimentos, así como por una inquietud desmedida por el peso y la forma corporales.
- Los síntomas o comportamientos dan lugar a un riesgo o daño considerables para la salud, una angustia notable o una discapacidad funcional importante.
- La anorexia nerviosa suele aparecer durante la adolescencia o a principios de la edad adulta y puede provocar una muerte prematura debido a complicaciones médicas o al suicidio.
- Las personas con bulimia nerviosa tienen un riesgo significativamente mayor de abuso de sustancias, suicidio y complicaciones de salud.

- Existen opciones de tratamiento eficaces, como el tratamiento de base familiar y la terapia cognitiva.
- Los trastornos de la conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia nerviosas, suelen aparecer durante la adolescencia y la juventud. Se manifiestan con conductas alimentarias anormales y preocupación por la alimentación y, en la mayoría de los casos, por el peso y la figura corporales, y son más frecuentes en las adolescentes que en los varones de esa misma franja de edad.
- Pueden afectar a la salud física y, a menudo, coexisten con la depresión, la ansiedad y el consumo indebido de sustancias.
- Se estima que afectan a un 0,1 % de los adolescentes de 10 a 14 años y a un 0,4 % de los de 15 a 19 años, y están asociados al suicidio.
- La anorexia nerviosa puede llevar a la muerte prematura, a menudo debido a complicaciones médicas o al suicidio, y su tasa de mortalidad es superior a la de cualquier otro trastorno mental.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*; OMS, \*Salud mental del adolescente\*.

### ### 6.5 Trastornos de comportamiento disruptivo y disocial

- En 2021, 41 millones de personas, incluidos niños y adolescentes, tenían un trastorno de comportamiento disocial.
- Este trastorno, también conocido como trastorno de conducta, es uno de los dos trastornos de comportamiento disruptivo y disocial; el otro es el trastorno desafiante y oposicionista.
- Los trastornos de comportamiento disruptivo y disocial se caracterizan por problemas de comportamiento persistentes, como comportamientos persistentemente desafiantes o desobedientes que violan de manera permanente los derechos básicos de los demás o las principales normas, reglas o leyes sociales apropiadas para la edad.
- Suelen aparecer durante la infancia, aunque no siempre es el caso.
- Existen tratamientos psicológicos eficaces, como la resolución de problemas cognitivos y/o la capacitación en habilidades sociales, en los que a menudo intervienen los progenitores, los cuidadores y los maestros.

**\*\*Fuente:\*\*** OMS, \*Trastornos mentales\*.

### ### 6.6 Trastornos del neurodesarrollo

- Los trastornos del neurodesarrollo son trastornos del comportamiento y cognitivos que surgen durante el desarrollo y que dan lugar a dificultades considerables en la adquisición y ejecución de funciones intelectuales, motoras o sociales específicas.
- Incluyen trastornos del desarrollo intelectual, trastorno del espectro autista y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), entre otros.
- El TDAH se caracteriza por un patrón persistente de falta de atención o hiperactividad-impulsividad que tiene un impacto negativo directo en el funcionamiento académico, ocupacional o social.

- Los trastornos del desarrollo intelectual se caracterizan por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y el comportamiento adaptativo, que se refiere a dificultades con las habilidades conceptuales, sociales y prácticas cotidianas en la vida diaria.
- El trastorno del espectro autista (TEA) constituye un grupo diverso de afecciones caracterizadas por cierto grado de dificultad con la comunicación social y la interacción social recíproca, así como patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos, repetitivos e inflexibles.
- Existen opciones terapéuticas eficaces, que incluyen intervenciones psicosociales y del comportamiento, terapia ocupacional y logoterapia. Para determinados diagnósticos y grupos de edad, también se puede considerar la medicación.

**\*\*Fuente:\*\* OMS, \*Trastornos mentales\*.**

---

## ## 7. Suicidio

### ### 7.1 Datos, factores de riesgo y señales de advertencia

- El suicidio es acabar con la propia vida. Con frecuencia, se ve como una manera de dar fin a la desesperanza o frustración abrumadora, o de resolver un problema para el que no se encuentra una solución.
- El suicidio de una persona joven es devastador para la familia, los amigos y la comunidad. Los padres, los hermanos, los compañeros de clase, los entrenadores y los vecinos tal vez se sientan enojados o culpables, o se pregunten si podrían haber hecho algo para impedirlo.
- El suicidio es la tercera causa de defunción entre los adolescentes mayores y los jóvenes (entre 15 y 29 años).
- En 2021, 727 000 personas se quitaron la vida.
- De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 10 y los 14 años, y la tercera causa de muerte entre los 15 y los 24 años, solo detrás de los accidentes y los homicidios.
- También se cree que por cada suicidio adolescente hay muchos más intentos de suicidio.
- Los factores de riesgo del suicidio son diversos: el consumo nocivo de bebidas alcohólicas, el maltrato en la infancia, la estigmatización (que disuade de buscar ayuda), los obstáculos que impiden recibir atención y el acceso a medios para suicidarse.
- Las plataformas digitales, al igual que otros medios, pueden desempeñar un papel importante a la hora de ayudar a aplicar medidas de prevención del suicidio, pero también pueden debilitar estas medidas.
- Aproximadamente el 95 % de las personas que fallecen debido a un suicidio tienen un trastorno psicológico en el momento de su muerte.
- Las cosas que pueden incrementar el riesgo de suicidio entre los adolescentes incluyen:
  - un trastorno psicológico, en especial la depresión, el trastorno bipolar y el consumo de alcohol y drogas;
  - sentimientos de angustia, irritabilidad o nerviosismo;

- sentimientos de desesperanza e impotencia, que suelen estar acompañados de depresión;
- un intento de suicidio anterior;
- antecedentes de depresión o suicidio en la familia;
- abuso sexual, emocional o físico;
- falta de una red de apoyo, malas relaciones con los padres o sus pares, y sentimiento de aislamiento social;
- problemas con la identidad de género o la sexualidad en una familia o una comunidad que no da apoyo.
- **\*\*Adolescentes en riesgo:\*\*** las personas jóvenes con problemas de salud mental, como ansiedad, depresión, trastorno bipolar o insomnio, tienen más riesgos de tener pensamientos suicidas. Los adolescentes que atraviesan grandes cambios en sus vidas (el divorcio de sus padres, una mudanza, la partida de uno de los padres debido al servicio militar o la separación de los padres, los cambios económicos) y quienes son víctimas del acoso escolar, el racismo o la estigmatización tienen más riesgos de tener pensamientos suicidas.
- **\*\*Señales de advertencia:\*\*** los adolescentes que están pensando en el suicidio tal vez hagan lo siguiente:
  - hablar sobre el suicidio o la muerte en general;
  - dar a entender que tal vez ya no estén aquí mucho tiempo;
  - hablar sobre sentimientos de desesperanza o de culpa;
  - alejarse de los amigos o la familia;
  - escribir canciones, poemas o cartas sobre la muerte, la separación y la pérdida;
  - comenzar a regalar posesiones muy queridas a sus hermanos o amigos;
  - perder el deseo de participar en sus actividades favoritas;
  - tener dificultad para concentrarse o pensar con claridad;
  - sufrir cambios en los hábitos de alimentación y de sueño;
  - comenzar a tener comportamientos de riesgo;
  - perder el interés en la escuela o los deportes.
- Los suicidios en los adolescentes suelen ocurrir después de un acontecimiento estresante, como problemas en la escuela, el fin de una relación con un novio o una novia, el fallecimiento de un ser querido, un divorcio o un grave conflicto familiar.
- **\*\*Acceso a medios:\*\*** el riesgo de suicidio se incrementa enormemente cuando los niños y los adolescentes tienen acceso a armas de fuego en el hogar, y cerca del 60 % de todos los suicidios de los Estados Unidos son cometidos con un arma de fuego. Por eso, si hay armas de fuego en el hogar, deben estar descargadas, bajo llave y fuera del alcance de los niños y los adolescentes.
- Las sobredosis con medicamentos de venta libre, con receta y sin receta también son un riesgo muy común para los intentos de suicidio y los suicidios. Es importante controlar atentamente todos los medicamentos que hay en el hogar. Los adolescentes intercambian diferentes medicamentos con receta en las escuelas y los llevan o almacenan en sus mochilas o casilleros.
- **\*\*Diferencias por sexo:\*\*** las muchachas piensan en suicidarse e intentan suicidarse con una frecuencia dos veces mayor a los muchachos y suelen intentar suicidarse con una sobredosis de drogas o cortándose. Sin embargo, la frecuencia de muertes por suicidio en los muchachos cuadruplica a la de las niñas. Los expertos creen que esto se debe a que suelen usar métodos más letales.

**\*\*Fuentes:\*\*** OMS, \*Salud mental del adolescente\*; KidsHealth, \*Suicidio\*; MedlinePlus, \*Evaluación del riesgo de suicidio\*.

### ### 7.2 Qué pueden hacer los padres y cuidadores

- Muchos adolescentes que se suicidan o intentan suicidarse advirtieron de alguna manera a sus seres queridos. Por eso, es importante que los padres sepan cuáles son las señales de advertencia para que los adolescentes que quizás tengan pensamientos suicidas puedan recibir la ayuda que necesitan.
- Si bien no siempre es posible prevenir un suicidio, siempre es conveniente estar informado y tomar medidas para ayudar a un adolescente atormentado.
- Algunos adultos creen que los niños o muchachos que dicen que se van a lastimar o quitar la vida “solo lo hacen para recibir atención”. Es importante darse cuenta de que si se ignora a un adolescente que está buscando atención, las probabilidades de que se autolesione son mayores.
- En general, los adolescentes no quieren recibir atención bajo la forma de visitas a la sala de emergencias, citas con los médicos y tratamientos en instituciones de salud mental, salvo que estén gravemente deprimidos y pensando en suicidarse o al menos deseando estar muertos. Es importante ver estas señales de advertencia como graves y no como un “pedido de atención” que se puede ignorar.
- **\*\*Observe y escuche:\*\*** observe atentamente a un adolescente deprimido y retraído. Comprender la depresión en los adolescentes es muy importante porque puede ser muy diferente de las creencias comunes acerca de la depresión. Por ejemplo, puede darse como problemas con los amigos, las calificaciones, el sueño o como mal humor o irritabilidad en lugar de tristeza crónica o llanto.
- Intente mantener abiertos los canales de comunicación y exprese su preocupación, su apoyo y su amor. Si su hijo adolescente le confía sus problemas, demuéstrole que toma en serio sus preocupaciones. Tal vez una pelea con un amigo a usted no le parezca tan importante, pero para un adolescente puede ser algo tremendo y agotador. No minimice ni ignore lo que le pasa.
- Si su hijo adolescente no se siente cómodo como para hablar con usted, sugiérale una persona más neutral, como otro pariente, un integrante del clero, un entrenador, un consejero escolar o su propio médico.
- **\*\*Haga preguntas:\*\*** algunos padres dudan si preguntarles a sus hijos adolescentes si han estado pensando en el suicidio o en autolesionarse. Algunos temen que hacer preguntas haga pensar a su hijo en la idea del suicidio. Siempre es una buena idea preguntar, aunque pueda ser difícil. A veces, explicar por qué hace esas preguntas puede resultar útil. Por ejemplo: “He notado que has estado hablando mucho de tu deseo de estar muerto. ¿Has estado pensando en quitarte la vida?”.
- **\*\*Cómo obtener ayuda:\*\*** si se entera de que su hijo está pensando en el suicidio, obtenga ayuda inmediatamente. El médico puede derivarlo a un psicólogo o psiquiatra, o el departamento de psiquiatría de su hospital local puede darle una lista de los médicos de su zona. La asociación de salud mental local o la sociedad médica del condado también pueden darle referencias. En caso de emergencia, llame al 1-888-628-9454 (para español) o envíe un mensaje de texto o llame al 988.
- Si su hijo adolescente está en una crisis, la sala de emergencias local puede hacer una evaluación psiquiátrica y derivarlo a los recursos adecuados. Si no está seguro de si debe llevar a su hijo a la sala de emergencias, llame al médico.
- Si tiene una visita programada con un profesional de la salud, no deje de acudir a ella, aun cuando su hijo adolescente le diga que se está sintiendo mejor o que no va a ir. Es normal que los pensamientos suicidas vayan y vengan. Pero su hijo adolescente necesita ayuda a fin de desarrollar las habilidades necesarias para mantener los pensamientos y las conductas suicidas bajo control durante una crisis.
- Si su hijo adolescente se niega a ir a la visita, dígaselo al profesional de la salud mental. Si usted acude a la sesión y trabaja con el médico, continuará teniendo acceso a la ayuda que su hijo necesita. El médico también puede conversar con usted sobre maneras de ayudar a que su hijo adolescente acepte ayuda.



- Recuerde que los conflictos entre un padre y un hijo pueden empeorar las cosas para los adolescentes que se sienten aislados, incomprensidos, desvalorizados o con tendencias suicidas. Obtenga ayuda para los problemas familiares y resuélvalos sanamente. Informe al profesional de la salud mental si su familia tiene antecedentes de depresión, abuso de sustancias o violencia doméstica. Hable sobre cualquier otra causa de estrés en el hogar, como un ambiente continuo de criticismo.

**\*\*Fuente:\*\* KidsHealth, \*Suicidio\*.**

### ### 7.3 Si perdió a un hijo debido a un suicidio

- Para los padres, la muerte de un hijo es la pérdida más dolorosa que se pueda imaginar. Para los padres que han perdido a un hijo debido a un suicidio, el dolor y la pérdida pueden ser más intensos. Estos sentimientos tal vez nunca desaparezcan por completo. Pero quienes sobreviven a un suicidio pueden tomar medidas para comenzar el proceso de sanación:

- **\*\*Manténgase en contacto con los demás.\*\*** El suicidio puede dejar aislados a los integrantes de la familia porque, con frecuencia, los amigos no saben qué decir o cómo ayudar. Busque personas que le den su apoyo y con quienes pueda hablar acerca de su hijo y de sus sentimientos. Si quienes lo rodean parecen sentirse incómodos o no saben cómo acercarse a usted, comience usted la conversación y pídale su ayuda.

- **\*\*Recuerde que los demás integrantes de su familia también están atravesando el duelo\*\*** y que cada uno expresa su dolor a su manera. Sus otros hijos, en especial, pueden intentar enfrentar el dolor solos para no sobrecargarlo. Estén el uno para el otro para compartir las lágrimas, el enojo y los silencios; y si es necesario, obtengan ayuda y apoyo juntos.

- **\*\*Sepa que los aniversarios, los cumpleaños o las fiestas pueden ser momentos muy duros.\*\*** Las fechas importantes y las fiestas suelen reavivar la sensación de pérdida y ansiedad. En esas fechas, haga lo que sea mejor para sus necesidades emocionales, ya sea rodearse de familiares y amigos, o planear un día sereno de reflexión.

- **\*\*Comprenda que es normal sentirse culpable y preguntarse cómo pudo ocurrir algo así.\*\*** Pero también es importante que se dé cuenta de que tal vez nunca encuentre las respuestas que busca. La sanación que se da con el tiempo surge de llegar a perdonar a su hijo y de perdonarse a usted mismo.

- **\*\*Los grupos de terapia y apoyo\*\*** pueden desempeñar un papel importante para ayudarlo a darse cuenta de que no está solo. A veces, los integrantes de la familia que están afligidos se convierten en parte de la red de prevención de suicidios que ayuda a los padres, los adolescentes y las escuelas a intentar prevenir futuras tragedias.

**\*\*Fuente:\*\* KidsHealth, \*Suicidio\*.**

### ### 7.4 Ayudar a los adolescentes a aceptar una pérdida

- ¿Qué debe hacer si alguien a quien su hijo adolescente conoce ha intentado suicidarse o se ha suicidado? En primer lugar, reconozca y valide las emociones de su hijo. Algunos adolescentes dicen sentirse culpables, en especial aquellos que sienten que podrían haber interpretado mejor las palabras y los actos de su amigo.

- Otros dicen sentirse enojados con la persona que se suicidó o intentó suicidarse por haber hecho algo tan egoísta. Y otros dicen que no sienten ninguna emoción intensa o que no saben cómo expresar lo que

sienten. Tranquilice a su hijo explicándole que no hay una manera correcta de sentirse y que está bien que hable del tema cuando se sienta preparado.

- Cuando una persona intenta suicidarse y sobrevive, las personas pueden tener miedo o sentirse incómodas como para hablar con ella sobre el tema. Dígale a su hijo que resista este impulso; este es un momento en el que una persona necesita sentirse conectada con los demás.

- Muchas escuelas abordan el suicidio de un estudiante llamando a un psicólogo especial para que hable con los estudiantes y los ayude a afrontar la situación. Si su hijo adolescente está enfrentando el suicidio de un amigo o un compañero de clase, anímelo a usar estos recursos o a hablar con usted u otro adulto en quien confíe.

**\*\*Fuente:\*\* KidsHealth, \*Suicidio\*.**

### ### 7.5 Evaluación del riesgo de suicidio

- **\*\*¿Qué es una evaluación del riesgo de suicidio?\*\*** El suicidio es la muerte que ocurre cuando una persona se daña a sí misma porque quiere acabar con su vida. Es una importante preocupación de salud pública y una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos y el mundo.

- El suicidio y los intentos de suicidio pueden tener efectos dañinos duraderos:

- Las personas que sobreviven un intento de suicidio pueden tener lesiones severas que pueden afectar su salud a largo plazo. También pueden tener depresión u otros problemas de salud mental.

- Cuando las personas mueren por suicidio, esto afecta a sus familiares, amigos y comunidades. Pueden sentir duelo, estrés agudo, enojo y culpa. Algunas personas pueden desarrollar estrés postraumático, depresión o ansiedad. También pueden tener más riesgo de presentar pensamientos suicidas.

- Con frecuencia, el suicidio puede prevenirse. Una evaluación del riesgo de suicidio puede ayudar a determinar la probabilidad de que una persona intente suicidarse. En la mayoría de las evaluaciones, un profesional de la salud hará algunas preguntas sobre el comportamiento y los sentimientos. Hay preguntas y pautas específicas que los profesionales de la salud pueden utilizar. A estas se las conoce como herramientas de evaluación del riesgo suicida. Si se determina que usted o un ser querido está en riesgo de suicidio, hay apoyo médico, psicológico y emocional disponible que puede evitar un desenlace trágico.

- **\*\*Nombres alternativos:\*\*** valoración del riesgo de suicidio.

- **\*\*¿Para qué se usa?\*\*** La evaluación del riesgo de suicidio se usa para averiguar si una persona está en riesgo de intentar suicidarse.

- **\*\*¿Por qué necesito una evaluación del riesgo de suicidio?\*\*** Usted o un ser querido podría necesitar una evaluación si nota cualquiera de los siguientes signos de advertencia:

- se siente sin esperanza o atrapado;
  - habla de ser una carga para los demás;
  - aumenta su consumo de alcohol o drogas;
  - tiene altibajos emocionales extremos;
  - tiene mayor ansiedad;
  - evita las situaciones sociales o quiere estar solo;
  - cambian sus hábitos de sueño o alimentación.

- La evaluación también puede ser útil para personas con estos signos y factores de riesgo de suicidio. Otras señales de advertencia pueden indicar que una persona tiene un riesgo inmediato de suicidio. Estas incluyen:

- hablar acerca del suicidio o querer morir;
  - buscar en internet formas para acabar con la vida, obtener un arma, acumular medicamentos como píldoras para dormir o medicamentos para el dolor;
  - hablar sobre no tener una razón para vivir.
- Si usted o un ser querido presenta cualquiera de estos signos de advertencia, busque ayuda de inmediato. Si hay una situación potencialmente mortal, llame al 911. De otra forma, contacte a un profesional de la salud mental o llame a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis al 988 (presione 2 para obtener ayuda en español).

- También puede necesitar una evaluación de riesgo de suicidio si tiene ciertos factores de riesgo. Usted puede tener más posibilidades de intentar hacerse daño si:

- ha tratado de quitarse la vida antes;
- tiene una enfermedad de salud mental como depresión u otro trastorno del estado de ánimo o trastorno por estrés postraumático (TEPT);
- tiene una enfermedad crónica o dolor crónico;
- tiene problemas legales;
- perdió su trabajo;
- tiene problemas financieros;
- tiene problemas en una relación o terminó una relación recientemente;
- está siendo acosado u hostigado;
- hay antecedentes de suicidio en su familia;
- presenta antecedentes de trauma o abuso;
- tiene antecedentes de trastorno por consumo de sustancias o alcohol.

- **\*\*¿Qué ocurre durante una evaluación del riesgo de suicidio?\*** Puede ser hecha por su profesional de la salud o un profesional de la salud mental. Un profesional de salud mental es un especialista en diagnosticar y tratar problemas de salud mental.

- El proveedor de atención médica puede hacerle un examen físico y preguntas sobre su consumo de alcohol o drogas, cambios en su alimentación y hábitos de sueño, y sobre altibajos emocionales. Estos pueden tener muchas causas. Tal vez le pregunte qué medicamentos recetados toma. Esto es importante porque, en algunos casos, los antidepresivos pueden aumentar los pensamientos de suicidio, especialmente en niños, adolescentes y adultos jóvenes (menores de 25 años). Quizás solicite un análisis de sangre u otras pruebas de laboratorio o de imágenes para ver si una enfermedad física puede estar causando los síntomas de suicidio.

- Su profesional de la salud puede usar una o más herramientas de evaluación del riesgo suicida. Estas herramientas son un tipo de cuestionario o pauta para los profesionales de la salud. Ayudan a evaluar su comportamiento, sus sentimientos y sus pensamientos de suicidio. Las herramientas de evaluación más comunes incluyen:

- **\*\*Cuestionario de salud del paciente-9 (PHQ9):\*** consta de 9 preguntas para diagnosticar, vigilar y medir la severidad de la depresión.

- **\*\*Preguntas de evaluación del suicidio (ASQ):\*** incluye 4 preguntas y es para personas jóvenes y adultas.

- **\*\*Breve evaluación de la seguridad del suicidio (BSSA):\*\*** si los resultados de las preguntas de evaluación de suicidio muestran que una persona está en riesgo, entonces se debe realizar esta evaluación. Un profesional de la salud capacitado es quien la realiza (como un trabajador social, enfermera, asistente médico u otro profesional de la salud mental). Se hace para determinar si se necesita una evaluación de salud mental más completa.
- **\*\*Evaluación y triaje de 5 pasos para la evaluación del suicidio (SAFE-T):\*\*** utiliza una evaluación de 5 pasos y un plan. Se usa para determinar el nivel de riesgo de suicidio de una persona. También incluye hacer un plan de tratamiento que enumere qué tipo de intervenciones se necesitan, basado en el nivel de riesgo. Ejemplos de intervención pueden incluir transferir a la persona a un hospital psiquiátrico local o referirla a más evaluaciones.
- **\*\*Escala de evaluación del riesgo de suicidio de Columbia (C-SSRS):\*\*** se basa en una serie de preguntas simples y fáciles de entender que determina el riesgo de suicidio.
- **\*\*¿Debo hacer algo para prepararme?\*** Esta evaluación no requiere ninguna preparación especial.
- **\*\*¿Tiene algún riesgo la evaluación?\*** Hacerse un examen físico o contestar un cuestionario no implica ningún riesgo.
- **\*\*¿Qué significan los resultados?\*** Si los resultados del examen físico o del análisis de sangre, prueba de laboratorio o prueba de imagen indican una enfermedad o un problema con un medicamento, su profesional de la salud puede ofrecerle tratamiento y cambiar o ajustar sus medicamentos según sea necesario.
- Los resultados de la herramienta de evaluación del riesgo suicida o de la escala de evaluación del riesgo de suicidio pueden mostrar la probabilidad de que usted intente suicidarse. El tratamiento depende del nivel de riesgo. Si su riesgo es muy alto, tal vez necesite una hospitalización. Si su riesgo es más moderado, el profesional de la salud puede recomendarle una o más de las siguientes medidas:
  - intervenciones breves como planificación de seguridad y llamadas de seguimiento: un plan de seguridad incluye una lista de habilidades de afrontamiento y personas a las que usted pueda llamar cuando necesite ayuda, así como un plan para mantenerse lejos de objetos con los que usted puede dañarse;
  - asesoría psicológica (terapia) con un profesional de salud mental: hay diferentes tipos de terapia que pueden utilizarse, incluyendo terapia familiar;
  - medicamentos, como antidepresivos: no obstante, las personas jóvenes que toman antidepresivos necesitan un seguimiento cercano. Estos medicamentos en ocasiones aumentan el riesgo de suicidio en niños y adultos jóvenes;
  - tratamiento para el trastorno por consumo de sustancias (si es necesario).
- **\*\*¿Debo saber algo más?\*** Si usted cree que está en riesgo de intentar suicidarse, obtenga ayuda de inmediato. Hay muchas maneras de recibir apoyo. Puede:
  - llamar al 911 o ir a su sala de emergencias local;
  - llamar o enviar un mensaje de texto a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio y Crisis al 988 (escribir AYUDA). Los veteranos de las Fuerzas Armadas pueden llamar al 988 (presione 1) para contactar a la Línea de Crisis para Veteranos;
  - chatear con un consejero en [988lifeline.org/es/chat/](https://988lifeline.org/es/chat/);
  - enviar un mensaje de texto a la línea del Centro de Crisis de Veteranos al 838255 o acceder al servicio de chat en línea;
  - llamar a su profesional de la salud o a su especialista de salud mental;
  - llamar a un ser querido o un amigo cercano.
- Si cree que un ser querido está en riesgo de suicidio, no lo deje solo. También debe:

- recomendarle que busque ayuda o ayudarlo a conseguirla si es necesario;
- hacerle saber que esto es importante para usted. Escuchar sin juzgar y ofrecer aliento y apoyo;
- mantenerlos alejados de armas, pastillas y otros artículos que puedan causar daño.

**\*\*Fuente:\*\* MedlinePlus, \*Evaluación del riesgo de suicidio\*.**

---

## ## 8. Autolesiones

- Es posible que resulte difícil comprender por qué un amigo se está lesionando a sí mismo a propósito. Suele ser complicado. Si un amigo se está cortando, lo más probable es que se esté enfrentando a emociones o problemas dolorosos y que no haya encontrado otras maneras adecuadas de afrontarlos.
- Algunas personas afirman que las conductas autolesivas las ayudan a distraerse con respecto a los problemas que tienen. O que las ayudan a desconectar de emociones dolorosas que les resultan difíciles de gestionar. Otras afirman que es una forma de expresar por fuera su dolor interno. Otras dicen que esas conductas les dan una sensación de alivio o de calma cuando se sienten muy saturadas o muy agobiadas. Otras afirman que se cortan para “despertar” y ser capaces de sentir algo.
- Pero lo que puede empezar como un intento de encontrarse mejor se puede acabar convirtiendo en un hábito nocivo que resulta difícil de romper.
- **\*\*¿La gente se autolesiona para llamar la atención?\*\*** La mayoría de las personas que se autolesionan no lo hacen para llamar la atención. Y la mayoría de ellas no tratan de matarse o suicidarse. Pero los cortes pueden causar sangrados o infecciones que no buscaba la persona e, incluso, heridas de riesgo vital.
- **\*\*¿Las conductas autolesivas pueden ser el signo de un problema de salud mental?\*\*** Algunas personas que se autolesionan tienen otro problema de salud mental que requiere atención. Hay algunas que han vivido traumas u otros acontecimientos vitales difíciles. Otras se sienten aisladas, rechazadas o solas.
- Autolesionarse no es una manera saludable de gestionar los problemas. Pero no tiene ningún sentido culpar a la persona que se autolesiona. Puede llevar tiempo, pero nunca es demasiado tarde para aprender maneras más saludables de afrontar las cosas. Y todo el mundo es capaz de hacerlo.
- **\*\*¿Un amigo puede marcar la diferencia?\*\*** Es posible que tú no puedas resolver los problemas de tu amigo. Eso es algo que debe hacer él o ella. Pero tu apoyo puede hacer grandes cosas. Y puede motivar a tu amigo a pedir la ayuda que necesita para encontrarse mejor.
- **\*\*Un amigo mío se podría estar cortando: ¿qué puedo hacer para ayudarlo?\*\***
  - La mayoría de las veces, las personas que se autolesionan no hablan sobre ello ni dejan que lo sepan los demás. Pero a veces se lo cuentan a un amigo. O un amigo lo puede descubrir de otra manera. Si no estás seguro de si un amigo tuyo se está cortando, he aquí algunas cosas que podrías probar:
    - **\*\*Saca el tema.\*\*** Si le has visto cicatrices o cortes que se le están curando, está bien que le digas algo al respecto. Dile a tu amigo qué es lo que has visto. Le puedes preguntar con amabilidad (y sin juzgarlo) si se está haciendo daño a sí mismo a propósito. Pregúntale si le gustaría hablar sobre por lo que está pasando. Pregúntale también cómo lo puedes ayudar.
    - **\*\*Ofrecete a hablar y escucha lo que te diga tu amigo.\*\*** Es posible que tu amigo no quiera hablar sobre ello. Pero tú le puedes dejar claro que a ti te importa y que estás disponible siempre que él quiera hablar contigo sobre ello. Si tu amigo sí que quiere hablar, no hace falta que le des respuestas ni consejos. La mayoría de las veces bastará con que le sepas escuchar.

- \*\*¿Y si le hablas sobre sus cortes y cicatrices y tu amigo se limita a cambiar de tema?\*\* Pruébalo otra vez. Haz que sepa que no lo vas a juzgar ni le vas a dar ningún sermón, que solo quieres lo mejor para él y que lo quieres ayudar.

- \*\*Pide ayuda a un adulto de confianza.\*\* Anima a tu amigo a hablar con un adulto de confianza. Ayúdale a pensar quién podría ser ese adulto. Te puedes ofrecer a acompañarlo. Si tu amigo no está preparado para dar ese paso, podrías hablar tú con un adulto. Podrías hablar con uno de tus padres, un orientador escolar, un profesor o un entrenador a quien aprecie tu amigo.

- \*\*Haz que ese adulto sepa que te preocupa tu amigo.\*\* Pide a ese adulto que se comunique con tu amigo o bien ayuda a tu amigo a buscar a un terapeuta.

- \*\*Si tu amigo te pide que lleves en secreto que se corta, le puedes decir que no sabes si podrás guardarle el secreto.\*\* Es posible que tu amigo se enfade mucho contigo al principio. Pero hablar con un adulto puede ser el primer paso para ayudar a tu amigo.

- \*\*Limitate a ser su amigo.\*\* Trata de entender la situación que está atravesando tu amigo. Pero no permitas que las autolesiones u otros problemas que tenga sean lo único sobre lo que hablen. Busca tiempo para hacer cosas juntos con las que ambos disfruten. Busca maneras de conectarse, cultivar la amistad y divertirse juntos. Tener un amigo de verdad que te cuida y que cree en ti puede marcar la diferencia. Y tú puedes ser esa persona para tu amigo.

- \*\*Cuida también de ti mismo y de tus sentimientos.\*\* Es normal que te afecte lo que le está pasando a tu amigo, y que estés triste o preocupado por él. Pero puede ser negativo para ti que te preocupes tanto por él que te llegues a obsesionar con sus problemas. Puede ser muy duro para ti que tu amigo se esté pasando por un momento difícil o que no quiera recibir ayuda.

- \*\*Asegúrate de recibir el apoyo que necesitas.\*\* Incluso aunque tu amigo no esté preparado para recibir ayuda, te puede ayudar el hecho de confiar en un adulto. Habla con un adulto de confianza sobre lo que está ocurriendo y sobre cómo te sientes.

- A veces, hasta los mejores amigos pueden necesitar tomarse un descanso con respecto a una situación tan intensa.

- \*\*Dale tiempo.\*\* Tú puedes dar lo mejor de ti mismo para animar a tu amigo a pedir ayuda. Pero él se podría cerrar a esa idea, por lo menos cuando tú se lo digas. Ten paciencia. Tu amigo podría necesitar tiempo para pensar en lo que le hayas dicho. Pero darle a entender de forma afectuosa que tú estás ahí es lo mejor que puedes hacer por él.

\*\*Fuente:\*\* KidsHealth, \*Autolesiones\*.

---

## ## 9. Redes sociales y salud mental

- La tecnología ha cambiado la forma en que interactuamos entre nosotros. Las redes sociales acercan a las personas con solo pulsar una tecla. Esto ayuda a algunos a sentir que tienen más apoyo social. Pero para otros, puede aumentar el aislamiento y la depresión.

- Los investigadores están estudiando cómo las redes sociales afectan la salud mental. Están descubriendo que las personas que se conocen y lo que se encuentra en línea pueden marcar la diferencia entre los efectos beneficiosos y los perjudiciales.

- \*\*Utilice su tiempo sabiamente:\*\* iniciar sesión en las redes sociales puede llevarlo en muchas direcciones. Participar activamente y conectarse con otros en línea puede ayudarlo a desarrollar apoyos

sociales, tanto en línea como fuera de línea. Pero pasar muchas horas desplazándose pasivamente a través de contenido perturbador puede enviarlo a una espiral de pensamientos y sentimientos negativos.

- El aumento del uso de las redes sociales se ha relacionado con síntomas de depresión, ansiedad y estrés. Pero no siempre está claro qué viene primero: ¿estar más tiempo en línea está causando los síntomas o es el resultado de los síntomas?

- La depresión o la ansiedad pueden hacer que uno se aíse. Pasar más tiempo en línea puede ser una señal de que se está alejando de los demás.

- Los estudios también han encontrado que algunas actividades en línea pueden empeorar la salud mental. Observar pasivamente lo que otros hacen en línea puede hacer sentir más aislado. Puede sentir que se está perdiendo de algo o que lo están dejando de lado. O puede hacerle pensar que otras personas tienen una vida mejor.

- Dónde hace clic afecta lo que ve a continuación. Si hace clic en las cosas que le molestan, es probable que se le muestren más de esas cosas. Pasar y ver repetidamente contenido perturbador puede aumentar su estrés y ansiedad.

- Los adolescentes corren un riesgo especial por los efectos de las redes sociales. Los estudios han encontrado vínculos entre los patrones en el uso de las redes sociales de los adolescentes y los problemas de salud mental.

- “Ha habido un aumento en el uso de las redes sociales, el uso de teléfonos inteligentes y la vida de los adolescentes en línea durante los últimos 10 años”, dice la Dra. Katherine Keyes de Columbia University. Las tasas de depresión y suicidio de los adolescentes también aumentaron en los últimos 10 años. Los investigadores han estado analizando el papel de las redes sociales en ese aumento.

- Los estudios de Keyes han demostrado que el uso de los medios digitales por sí solo no explica estos aumentos recientes de la depresión y el suicidio. Otros factores también deben estar presentes. Se necesita más investigación para averiguar cuáles son.

- Lo que parece más importante es cómo los adolescentes usan las redes sociales y cómo su tiempo en línea afecta sus actividades y redes sociales fuera de línea, dice Keyes.

- En otras palabras, el tiempo en línea quita el tiempo que se podría estar usando para estar con otras personas, hacer actividad física o practicar un pasatiempo. Estas son cosas que ayudan a proteger la salud mental.

- **\*\*Haga conexiones con cautela:\*\*** se pueden encontrar innumerables personas y comunidades diferentes en línea. “Se pueden hacer muchas conexiones significativas y beneficiosas en línea”, dice Keyes. “Esto es especialmente cierto para los adolescentes que tienen identidades más marginadas. A veces pueden encontrar comunidad y conexión en línea que no pueden obtener en su vida cotidiana”.

- Pero el mundo digital también puede exponerlo a comportamientos nocivos para la salud. El consumo excesivo de alcohol, el consumo de sustancias y los trastornos alimentarios a veces se muestran engañosamente como algo que todos están haciendo o quieren hacer.

- Las personas también ven anuncios sobre el consumo de tabaco, el consumo de cannabis y el consumo de alcohol en línea. La Dra. Patricia Cavazos-Rehg de Washington University in St. Louis estudia los efectos de los anuncios en el consumo de sustancias entre los adolescentes. Su investigación ha demostrado que incluso ver contenido de tabaco en línea de forma pasiva aumenta la probabilidad de usar productos de tabaco. Keyes encontró tendencias similares para el alcohol y el cannabis.

- “Mi preocupación es que las redes sociales pueden hacer que los comportamientos de consumo de sustancias parezcan normales”, explica Cavazos-Rehg. Eso puede afectar tanto a adolescentes como a adultos.

- “Hemos visto muchos mensajes en línea sobre la cultura de las ‘mamá del vino’ que relacionan el consumo de alcohol con ‘mamá necesita un descanso al final del día’”, dice Keyes. “Estos mensajes vinculan el alcohol con el cuidado personal positivo”. Pero usar el alcohol para controlar el estrés no es una estrategia de afrontamiento saludable. En los últimos años, las mujeres han tenido un mayor aumento en el consumo de alcohol que los hombres.

- Cavazos-Rehg está investigando formas de brindar información sobre los riesgos del consumo de sustancias en las redes sociales. También está analizando cómo hacer llegar información de tratamiento de calidad a las personas que hablan sobre problemas de salud mental y consumo de sustancias en línea.

- **\*\*Busque ayuda:\*\*** las redes sociales pueden ser una herramienta para mejorar la salud mental. Se puede buscar información de salud, conocer las experiencias de otros o encontrar opciones de tratamiento.

- “Descubrimos que las redes sociales pueden ser muy útiles para las personas que se sienten estigmatizadas por la recuperación en persona”, dice Cavazos-Rehg. “Además, las redes sociales pueden ayudar a aquellos que tienen curiosidad o están listos para participar en un tratamiento, pero primero quieren el consejo de sus pares en línea”.

- Su equipo analizó qué impide que las personas con síntomas de depresión busquen tratamiento. Descubrieron que muchas personas se preocupan por ser estigmatizadas. Otros tienen problemas para acceder o pagar el tratamiento.

- Su equipo está buscando formas de reducir esas barreras a través de las redes sociales. Han creado herramientas para identificar publicaciones en las redes sociales que pueden indicar que alguien necesita tratamiento para un trastorno alimentario. También crearon una aplicación de tratamiento para adolescentes con trastornos alimentarios. Asimismo, el equipo está trabajando para llegar a los adolescentes que necesitan tratamiento a través de anuncios en línea.

- “Hay mucho apoyo para la recuperación y la salud mental que las personas pueden obtener de las redes sociales”, dice Cavazos-Rehg. “Pero a menudo hay información errónea que también puede propagarse”. Encontrar consejos para evaluar la información de salud en línea en:

- <https://www.nccih.nih.gov/health/finding-and-evaluating-online-resources>

- <https://www.nia.nih.gov/espanol/confiable-informacion-sobre-salud-se-encuentra-internet>

- Recuerde, no necesita luchar con los problemas de salud mental usted solo. “Existe una idea errónea común de que podemos manejar nuestros problemas de salud mental por nuestra cuenta y de que no son lo suficientemente graves como para justificar atención médica”, dice Cavazos-Rehg. “Pero eso es un concepto erróneo”. No dude en comunicarse con un proveedor de atención médica o un profesional de la salud mental.

- **\*\*Elecciones sabias:\*\***

- **\*\*Cuidar la salud mental:\*\*** cuide su cuerpo y su mente. Siga un horario, coma bien, manténgase físicamente activo, duerma bien, manténgase hidratado y pase tiempo al aire libre.

- **\*\*Cultive relaciones saludables:\*\*** la socialización es un poderoso amortiguador del estrés y una fuente de bienestar. Pase tiempo con otras personas con regularidad, de forma presencial y virtual.

- **\*\*Reflexione sobre su uso de las redes sociales, los videojuegos y otras tecnologías.\*\*** Pregúntese: ¿Cuánto tiempo estoy pasando en línea? ¿Esto me quita tiempo para realizar actividades saludables fuera de línea, como hacer ejercicio, ver amigos, leer o dormir? ¿Qué contenido veo y cómo me hace sentir?

- **\*\*Aprenda a manejar el estrés y otras emociones difíciles.\*\*** Trate de reconocer situaciones que puedan ser emocionalmente desafiantes e idee estrategias para manejar esas emociones.

- **\*\*Pida ayuda.\*\*** Encuentre a alguien en quien confíe para hablar sobre situaciones estresantes. Si tiene dificultades para controlar las emociones negativas, comuníquese con un proveedor de atención médica, un consejero o una persona de confianza.

- Llame o envíe un mensaje de texto a la línea de prevención del suicidio y crisis al 988 si usted o alguien que conoce está en crisis.

- Obtenga ayuda para encontrar tratamiento para el abuso de sustancias y la salud mental en su área. Llame a la línea de ayuda nacional gratuita al 1-800-662-HELP (4357) o visite [www.FindTreatment.gov](http://www.FindTreatment.gov).

**\*\*Fuente:\*\*** NIH, \*Hábitos saludables en las redes sociales\*.



---

## ## 10. Recursos de ayuda y crisis

- **Línea de prevención del suicidio y crisis 988:** puede llamar al 1-888-628-9454 o puede enviar un mensaje de texto o llamar al 988. También es posible contactar a través de su página web. En situaciones potencialmente mortales, llame al 911.
- **Línea de la Esperanza Trevor para la comunidad LGBTQ:** 1-866-488-7386 o puede enviar el mensaje de texto “START” al 678678. También puede comunicarse a través de su página web.
- **Veteranos de las Fuerzas Armadas:** pueden llamar al 988 (presione 1) para contactar a la Línea de Crisis para Veteranos; también pueden enviar un mensaje de texto al 838255 o acceder al servicio de chat en línea.
- **Ayuda para abuso de sustancias y salud mental:** llame a la línea de ayuda nacional gratuita al 1-800-662-HELP (4357) o visite [www.FindTreatment.gov](http://www.FindTreatment.gov).
- **Información sobre cómo encontrar apoyo y localizar servicios de salud mental:** Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental (SAMHSA).
- **Estudios clínicos:** los estudios clínicos son estudios de investigación que analizan nuevas formas de prevenir, detectar o tratar enfermedades y afecciones. Estos estudios ayudan a determinar si un tratamiento es seguro y eficaz en las personas. Algunas personas participan para ayudar a los médicos y los investigadores a aprender más sobre una enfermedad y mejorar la atención médica. Otras personas, como las que tienen alguna afección de salud, participan para probar tratamientos que no están disponibles con facilidad. El NIMH apoya estudios clínicos en diferentes áreas de los Estados Unidos. Hable con un proveedor de atención médica sobre estos estudios y si alguno es adecuado para usted.

**Fuentes:** NIMH; MedlinePlus; KidsHealth; NIH.

---

## ## 11. Fuentes

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
- Estudio *\*Salud Mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemia\**.
- OMS. *\*Salud mental del adolescente\**:  
<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
- OMS. *\*Trastornos mentales\**: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders>
- OMS. *\*Trastornos de ansiedad\**: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anxiety-disorders>
- OMS. *\*Depresión\**: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression>
- NIMH. Publicaciones en español: <https://www.nimh.nih.gov/health/publications/espanol>
- MedlinePlus. *\*Salud mental de adolescentes\**:  
[https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html#cat\\_47](https://medlineplus.gov/spanish/teenmentalhealth.html#cat_47)

- KidsHealth. \*Autolesiones\*: <https://kidshealth.org/es/teens/friend-cuts.html>

- NIH. \*Hábitos saludables en las redes sociales\*:

<https://salud.nih.gov/recursos-de-salud/nih-noticias-de-salud/habitos-saludables-en-las-redes-sociales>

- KidsHealth. \*Suicidio\*: <https://kidshealth.org/es/parents/suicide.html>

- MedlinePlus. \*Evaluación del riesgo de suicidio\*:

<https://medlineplus.gov/spanish/pruebas-de-laboratorio/evaluacion-del-riesgo-de-suicidio/>